
Patologia Oral Diagnóstico Integrado

Aulas de Diagnóstico Integrado I e 2

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Lesões Fundamentais – Definições	3
02 Alterações Não Patológicas da Mucosa Oral	5
03 Alterações Não Patológicas da Mucosa Oral (parte 2)	11
04 Lesões Bacterianas	15
05 Lesões Bacterianas (parte 2)	20
06 Lesões Virais e Bacterianas	24
07 Lesões Virais e Bacterianas (parte 2)	29
08 Úlcera Aftosa Recorrente (Afta)	32
09 Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN)	35
10 Neoplasias	38
11 Anomalias Dentárias de Desenvolvimento	44
12 Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 2)	49
13 Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 3)	55
14 Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 4)	62
15 Lesões do Órgão Dentário	65
16 Lesões do Órgão Dentário (parte 2)	70
17 Lesões do Órgão Dentário (parte 3)	75
18 Lesões do Órgão Dentário (parte 4)	80
19 Lesões do Periodonto e do Periápice	85
20 Lesões do Periodonto e do Periápice (parte 2)	90
21 Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral	94
22 Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 2)	100
23 Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 3)	104
24 Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 4)	108
25 Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 5)	113
26 Pseudocistos	118
27 Cistos Não Odontogênicos	120
28 Biópsia e Citologia Esfoliativa	122
29 Biópsia e Citologia Esfoliativa (parte 2)	127

01

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Fundamentais – Definições

Aula ministrada pela Dra. Profa. Nathalia Tuany, em 10 de maio de 2022. Como material de apoio foi utilizado “Estomatologia para clínicos da atenção básica do Município de São Paulo”.

LESÕES FUNDAMENTAIS

Divididas em 3 tipos:

PONTOS-CHAVE

Alterações de cor: mácula = lesão fundamental - mancha.

Alterações de volume: *FORMAÇÃO SÓLIDA* = placa; nódulo; pápulas. *CONTEÚDO LÍQUIDO* = vesícula; bolha.

Perda tecidual: úlcera e erosão.

Mácula ou mancha

Alteração de cor sem elevação ou depressão podendo ter origem exógena ou endógena.

Ex: tatuagem por amálgama, pigmentação melânica, melanoma.

Placa

Alteração de cor com alteração de superfície, ou seja, com discreta elevação mais ampla em largura que em altura.

Ex: queratose friccional, candidíase pseudomembranosa.

Pápula

Elevação circunscrita, bem delimitada, menor que 5 mm de diâmetro podendo ser séssil ou pediculada.

Ex: grânulos de Fordyce, hiperplasia fibrosa inflamatória.

Nódulo

Elevação circunscrita, bem delimitada, maior que 5 mm de diâmetro e menor que 3 cm, podendo ser séssil ou pediculada.

Ex: Fibroma, fibroma ossificante periférico, fibroma traumático.

Vesícula

Lesão elevada com conteúdo líquido em seu interior com até 3 mm de diâmetro.

Ex: mucocelo, herpes, gengivostomatite herpética aguda (possui conteúdos).

Bolhas

Lesão elevada com conteúdo líquido em seu interior com mais de 3 mm de diâmetro.

Ex: rânula, pênfigo vulgar.

Erosão

Perda parcial do tecido epitelial sem atingir o tecido conjuntivo adjacente.

Ex: líquen plano erosivo, candidíase, língua geográfica.

Úlceras

Perda do tecido epitelial com exposição do tecido conjuntivo adjacente.

Ex: Carcinoma espinocelular, úlcera traumática, gengivostomatite herpética (após estourar a vesícula), afta maior.

ANOTAÇÕES

02

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Alterações Não Patológicas da Mucosa Oral

Língua Geográfica

PONTOS-CHAVE

Sinonimias: eritema migratório, glossite migratório benigna, estomatite migratória.

Etiologia desconhecida.

Mais frequente em mulheres (2:1).

Alterações na língua com sensibilidade aumentando em alguns períodos, principalmente com alimentos condimentados ou quentes.

Áreas despapiladas circundes por halo esbranquiçado.

Tratamento: Desnecessário.



Há uma forte associação entre a unha geográfica e a fissurada, pois foi encontrado casos com ambas as condições. A base hereditária tem sido sugerida para a língua geográfica, os mesmos genes podem estar relacionados com as duas condições. Inclusive, foi sugerido que a linha geográfica pode causar a língua fissura.

Língua Fissurada

Sinonimia: língua escrotal.

Etiologia desconhecida.

Crianças e adultos, com predileção pelo sexo masculino.

Inúmeras fendas e formas variadas no dorso lingual, variando de 2 a 6 mm de profundidade.

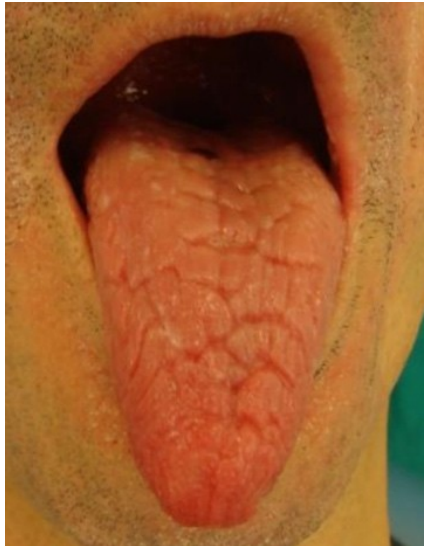
Em casos mais graves há numerosas fissuras que cobrem completamente a superfície dorsal e divide a pupilas linguais em múltiplas "ilhas".

Hereditariedade é um papel importante.

Causa incerta.

Fatores ambientais e idade contribuem para o desenvolvimento.

Tratamento: Desnecessário, porém o paciente deve ser instruído a escovar a língua.



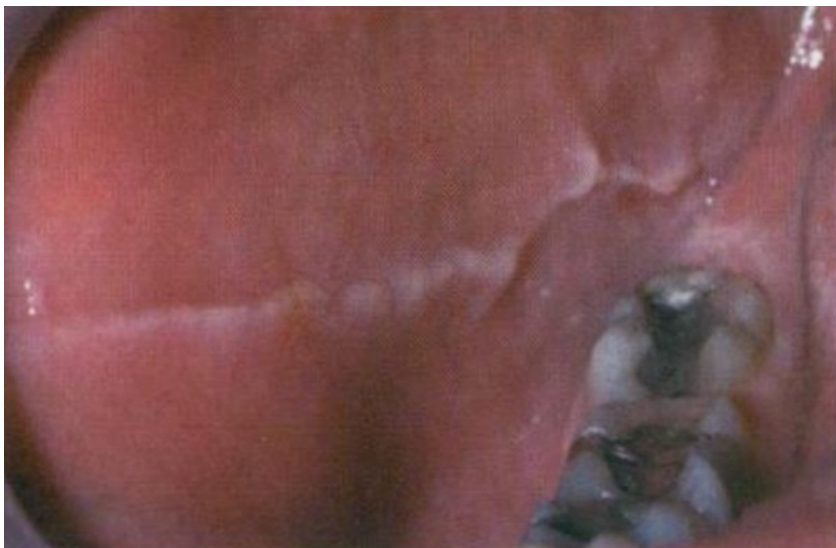
Linha Alba

Alteração comum da mucosa jugal, mais provavelmente associada à irritação por fricção, pressão ou turma por sucção.

Frequentemente nominada "linha de mordida" é localizado bilateralmente, próxima aos dentes posteriores.

Predomínio pelo sexo feminino.

Tratamento: Desnecessário. Porém em alguns casos é necessário a biópsia.



Morsicatio buccarum laboram

Mastigação crônica da bochecha.

Mucosa mordiscado.

Etiologia: hábito de morder a mucosa jugal ou lábio.

Lesão comum em músicos e vidreiros (assopram vidro).

É bastante encontrado em pessoas sob estresse ou que exibem quadros psicológicos.

Prevalência em mulheres com mai de 35 anos de idade.

Tratamento: Desnecessário.



Nevo branco esponjoso (doença de Cannon)

- Alteração hereditária rara.
- Herdada como traço autossômico dominante.
- Defeito na queratinização normal da mucosa oral.
- Lesões esbranquiçadas.
- Não são pre-cancerígenas.
- Os pacientes em geral são assintomáticos.

Tratamento: Desnecessário.



Leucoedema

- Lesão comum da mucosa jugal de causa desconhecida.
- Ocorre mais em indivíduos negros — presença de pigmentação na mucosa.
- Quando é encontrado em indivíduos brancos a sua visualização é difícil.
- Podemos definir como uma variação da normalidade.
- Mais comum em tabagistas, e se torna menos pronunciado quando o paciente abandona o hábito.
- Aspectos clínicos:** aparência difusa opalescente, leitosa, branco-acinzentada da mucosa.
- Ocorre bilateralmente a mucosa jugal e pôde-se estender ate a mucosa labial.
- Não é removida a raspagem.

Tratamento: Não há. A mucosa afete sempre deve ser distendida durante o exame clínico, assim, esta alteração não patológica ira desaparecer.



Pigmentação fisiológica racial

Apresenta-se como uma faixa simétrica pigmentada, que varia do marrom ao negro.

Tratamento: Desnecessário.



Mácula melanótica oral

Pigmentação plana e marrom da mucosa produzida pelo aumento localizado da deposição de melanina

Não depende da exposição ao sol.

Bem demarcada e solitária.

Amarelo-acastanhada, marrom-escuro, azuis ou negras.

Tratamento: Desnecessário.



Língua pilosa

Acentuado acúmulo de queratina nas papila filiformes a superfície dorsal da língua, lembrando cabelos ou pelos. Causa incerto, porém muitos pacientes afetados são fumantes. Além de higiene deficiente, drogas que induzam a hipossalivação e um histórico de radioterapia na região de cabeça e pescoço.

Assintomática, porém em alguns casos alguns pacientes queixam-se de náuseas e um gosto desagradável na boca.

A biópsia se torna necessária em alguns casos.



Tratamento: Remover fatores associados e escovação da língua.

Glossite mediana rombica

Sinonímia: atrofia papilar central.

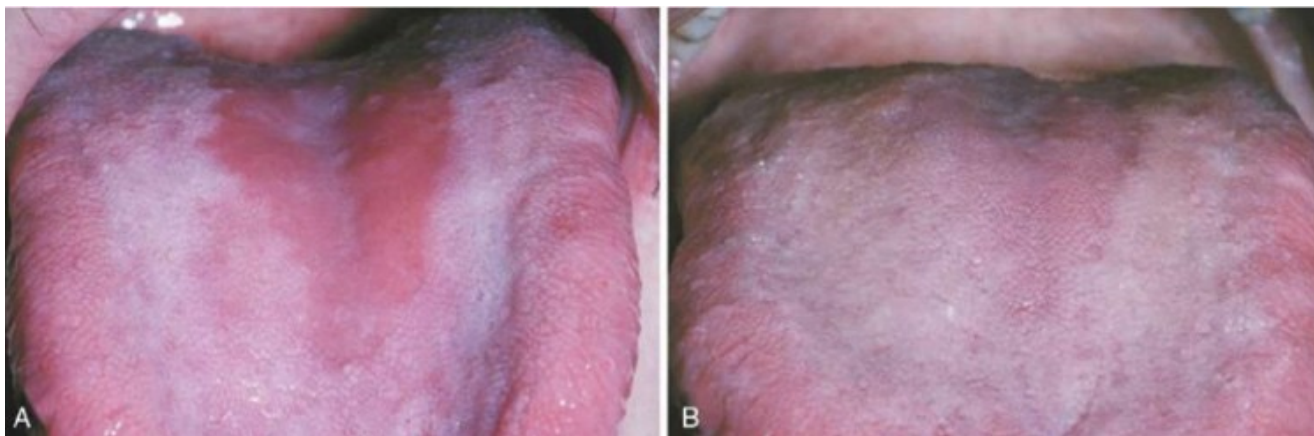
Provável origem: infecção fúngica por *Candida sp* ou congênita.

Áreas vermelhas, com atrofia da mucosa, assintomática.

Região posterior da língua, dorso na linha média.

Alguns pacientes podem exibir sinais de infecção da mucosa oral por *Candida* em outros sítios.

Tratamento: Desnecessário.



Língua crenada

É um dos tipos de amiloidose.

É raro ser descrita em tecidos moles.

É uma amiloidose sistêmica, de característica primária é associada a mieloma.



Grânulos de Fordyce

Glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa bucal.

Podem ser consideradas “ectópicas”

Múltiplas pápulas amareladas.

Mais comum em mucosa jugal e vermelhão do lábio.

Mais comum em adultos.

Variação anatômica normal.

ANOTAÇÕES

03

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Alterações Não Patológicas da Mucosa Oral (parte 2)

PONTOS-CHAVE

Assintomáticas.

A quantidade de grânulos pode variar em, pacientes com poucos, ou com muitos.

Tratamento: Desnecessário.



Varicosidades lingual

Sinonímia: varizes.

Veia anormalmente dilatada e tortuosas.

Causa incerta.

Raros em crianças, comum em idosos.

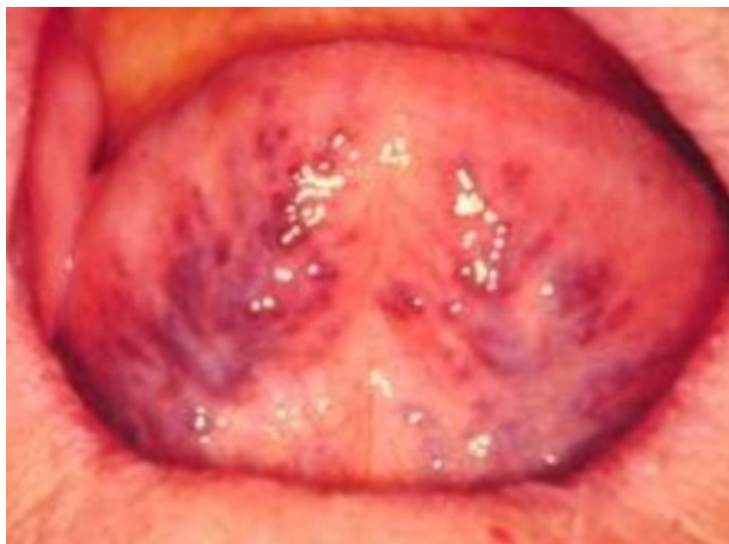
Mais comum: sublingual.

Assintomáticas.

A idade é um fator etiológico importante.

Pacientes com varizes nas pernas é mais propenso ter na língua.

Tratamento: Desnecessário.



Ductos de glândulas salivares

Ductos de Stensen: glândula parótida – Muito comum estar aumentado e ser confundido com alguma lesão.

Ductos de Wharton: submandibular.

Ductos de Bartholin: sublinguais.



Fossetas da comissura labial

Pequenas invaginações da mucosa na comissura labial.

Achados de rotina.

Assintomáticas.

Uni ou bilateral.

Limite do vermelhão dos lábios, nos ângulos da boca.

Tratamento: Desnecessário.



Tórus palatino

Exostose comum que ocorre na linha média do palato.

Origem genética ou influência de fatores ambientais, como o estresse mastigatório.

Crescimento lento, indolor.

Diagnóstico clínico.

Massa dura de osso.

São classificados de acordo com a sua aparência morfológica:

O **tórus plano** tem uma base ampla e uma superfície lisa, ligeiramente convexa. Ele se estende de forma simétrica para os dois lados da rafe palatina.

O **tórus alongado** apresenta-se como uma crista na linha média ao longo da rafe palatina. Algumas vezes há um sulco central.

O **tórus nodular** apresenta-se como protuberâncias múltiplas, cada uma com sua base. Essas protuberâncias podem coalescer, formando sulcos entre si.

O **tórus lobular** também é uma massa lobulada, porém origina-se de uma base única. O tórus lobular pode ser séssil ou pediculado.

Tratamento: Somente quando necessário. E quando necessário é preciso realizar uma biópsia, e também a cirurgia para remoção também é indicada dependendo do tamanho este torus.



Tórus mandibular

Exostose comum na mandíbula.

Influência genética ou de fatores ambientais.

Região lingual, pré-molares.

Bilateral em 90% dos casos.

Mass dura de osso.

Achado clínico.

Tratamento: Somente quando necessário, como em próteses, realizamos a remoção cirúrgica. As vezes é necessário a reco por acúmulo de alimentos, é difícil acesso a higienização.



Exostose vestibular

Afetam a mandíbula e a maxila, porem este tipo afeta a área vestibular.
Crescimento ósseo.



Tratamento: Não há um tratamento, porem quando necessário remoção, é preciso fazer um biópsia. A remoção as vezes se torna necessária pra facilitar na higiene, ou as vezes por acoplar próteses.

ANOTAÇÕES

04

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Bacterianas

Aula ministrada pela Dra. Profa. Nathalia Tuany, em 10 de maio de 2022.

Sífilis



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville



Kutsuna S. Fujiya Y. Primary and Secondary Syphilis as Chancre of the Mouth with Rash.

PONTOS-CHAVE

Treponema Pallidum (espiroqueta

com 10 a 15 espiras — 8 micrometros de comprimento) — anaeróbia facultativa — baixa resistência ao meio ambiente (calor e falta de umidade) e muito sensível a ação do sabão e outros desinfetantes.

Adere ao epitélio e invade a corrente circulatória.

Taxa lenta de metabolização - 30 horas para multiplicar-se.

Não confere imunidade - ou seja, o paciente teve sífilis uma vez, e pode ter novamente.

Contato sexual ou vertical (pela mãe).

Anaeróbica facultativa.

Penicilina 1940 - diminuição de casos.

ADQUIRIDA:

Lesões Primárias: logo após o contato com a bactéria. Muito importante a ação do CD. **MANIFESTAÇÕES ORAIS:** Cancro; 10 a 90 dias após a exposição; Soluciona espontaneamente; Indolores, sem sintomatologia sistêmica; Boca (lábio, língua, palato); Úlceras de base endurecida; Biópsia; As lesões só parecem no local da inoculação (10 a 90 dias); Mesmo na ausência de tratamento o quadro clínico evolui espontaneamente após 2 a 6 semanas;

Lesões Secundárias:



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville



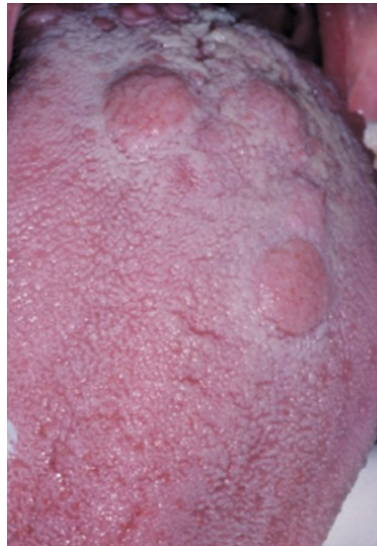
Oral and Maxillofacial Pathology- Neville

Latente recente - menos de 1 ano após a primária.

Latente tardia - mais de 1 ano após a primária volta a dar sinais clínicos. **SINTOMATOLOGIA SISTÊMICA:** Dor de garganta; Mal estar; Cefaleia; Febre; Perda de peso; Dores musculoesqueléticas; Exantema cutâneo maculopapular; Linfadenopatia;

LESÕES CLÍNICAS (mãos e pés, prurido): Roséolas; Pápulas eritomas; Lesões eritomato - descamativas; Erupções pustulares; Lesões pápulo erosivas ou condiloma plano; Alopecia com clareira;

MANIFESTAÇÕES ORAIS:



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville 30% dos pacientes; Placas mucosas multifocais (úlceras rosas irregulares, recobertas por membranas superficiais acinzentadas que pode ser destacada); Placas esbranquiçadas; Língua, lábios, mucosa jugal e palato;

Condiloma Lata - nódulos papilares múltiplos.

Lesões Terciárias:

Pode ser reativada depois de anos;

Complicações vasculares (10%);

Complicações em SNC (7%);

Pele, mucosa, tecidos moles, ossos e órgãos internos (15%) - sífilis tardia benigna;

Mucosa oral - lesões inflamatórias granulomatosas destrutivas;

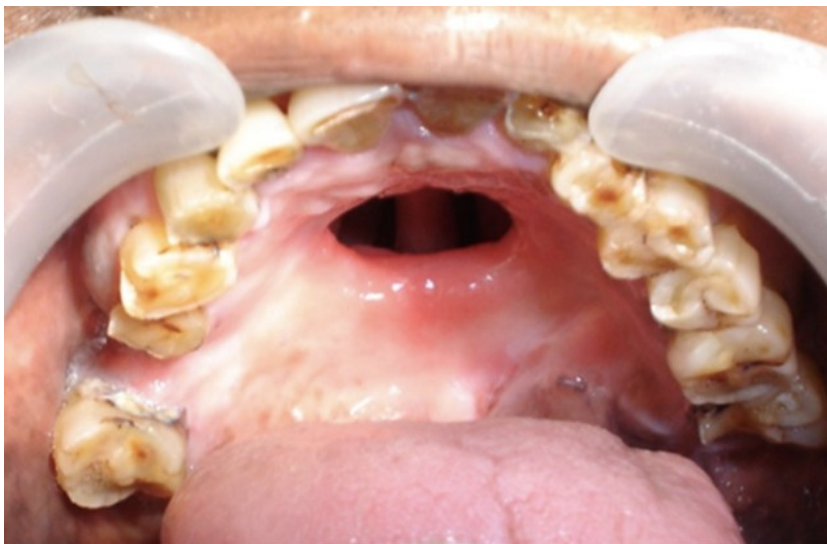
Lesões nodulares ou ulceradas (goma) levando a grandes perdas de tecido;

Palato - comunicações buco-sinusais; Língua - glossite luética;

MANIFESTAÇÕES ORAIS:

Comprometimento sistêmico;

Perfuração no palato - GOMA;



Murthy V, et al. Prosthetic rehabilitation of palatal perforation in a patient with 'syphilis: the great imitator'.

CONGÊNITA:

- Ocorre durante a gestação ou nascimento.
- Precoce (logo após o parto).
- Tardia.
- É uma doença de notificação compulsória nacional e estadual.
- Precoce (até os 2 anos).
- Quanto mais precoce os sinais clínicos maior a gravidade.
- Tardia - morbidade - hepatomegalia, petequias, periosteites.

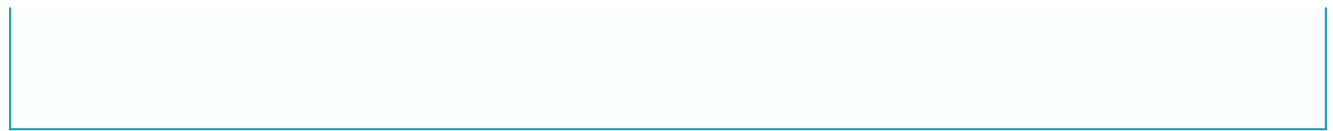
MANIFESTAÇÕES ORAIS:

- Alterações dentárias - *incisivos de Hutchinson e Molares em Amora* —> aumento de deposição de esmalte, aumentando a oclusal do dente; incisivos em forma de chave de fenda.



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville

ANOTAÇÕES



05

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Bacterianas (parte 2)



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville

PONTOS-CHAVE

Surdez (oitavo nervo) e ceratite ocular (superficial de córnea opacifica = esgueira - 5 a 25 anos).

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO:

Primária - biópsias e identificação do MO.

Secundária- sorologia / biópsias (as vezes).

Terciária- sorologia e liquor.

Testes treponêmicos - FTA-abs (não sabe se o pcte está com a doença no presente ou teve no passado).

Testes não treponêmicos - VDRL -determina infecção ativa.

Sorológico.

Imunofluorescência.

Penicilina e Doxorubicina -> PREVENTIVO.

VDRL	FTA-ABS	RESULTADO
+	+	Sífilis
+	-	Outra doença
-	+	Sífilis inicial, curada ou terciária
-	-	Descrita sífilis

O exame FTA-ABS é um exame laboratorial que tem como objetivo diagnosticar e monitorar a resposta ao tratamento para SÍFILIS, também conhecida como lues, que é uma infecção sexualmente transmissível. NÃO SABE-SE O PACIENTE ESTÁ COM A DOENÇA NO PRESENTE OU TEVE NO PASSADO.

O exame VDRL corresponde a testes específicos, úteis para confirmação diagnóstica. A sensibilidade dos testes treponêmicos na sífilis adquirida é de 84% na fase primária, de 100% nas fases secundárias e latente, e de aproximadamente 96% na sífilis terciária. DETERMINA A INFECÇÃO ATIVA.

Tuberculose

Mycobacterium tuberculosis.

Problema de saúde mundial.

Maior prevalência em homens.

FORMAS DE CONTÁGIO - gotículas respiratórias infectadas.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO:

Identificação do bacilo - Coloração BAAR.

Biópsia, cultura.

Tratamento - esquema RIPE.

FASE 1 2 MESES - RIPE

**R - RIFAMPICINA I - ISONIAZIDA P - PIRAZINAMIDA
E - ETAMBUTOL**

Fase 2 4 meses - RI

R - RIFAMPICINA I - ISONIAZIDA

PRIMÁRIA - primeiro sítio de contato -principalmente pulmão.

Nódulos fibrocalcificantes latentes -assintomáticos.

SECUNDÁRIA - reativação - imunidade baixa.

Extrapulmonar - aumentos linfonodais e lesões orais.

MANIFESTAÇÕES ORAIS:

Incomum.

Ulcerações crônicas e lesões granulomatosas.



Khateeb D et al. Oral Tuberculosis: A Rare Manifestation of Disseminated Disease in a Patient with Dermatomyositis on Chronic Corticosteroids. Case Rep Med.



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville

Actinomicose

Actinomyces Israelii.

Presente na flora bucal.

Infecção aguda ou crônica.

55% cervicofacial.



Meshkan Moghimi et al. Treatment of Cervicofacial Actinomycosis: A report of 19 cases and review of literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO:

Diagnóstico clínico e histopatológico.

Tratamento altas doses de antibiótico de uso prolongado + drenagem (ou remoção da lesão).



Oral and Maxillofacial Pathology - Neville

ANOTAÇÕES

06

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Virais e Bacterianas

Herpes vírus (lesão viral)

Latência: é a diferença de tempo entre o início de um evento e o momento em que os seus efeitos se tornam perceptíveis

PONTOS-CHAVE

HSV1 — boca e nariz.

HSV2 — regiões genitais.

Gengivoestomatite herpética HSV1



Etiologia: infecção primária pelo HHV 1.

É comum na infância (6 meses a 5 anos e idade) — pico de prevalência 2 a 3 anos.

Antes dos 6 meses é raro devido anticorpos da mãe.

Mais raras mas podem ocorrer em pacientes mais velhos.

Sintomatologia: febre, cefaleia e aumento de linfonodos submandibulares.

Incubação +/- 6 dias.

Sinais clínicos:

Diversas vesículas puntiformes que rapidamente se rompem e formam inúmeras lesões pequenas avermelhadas.

Aumentam pouco de tamanho e desenvolvem áreas centrais de ulceração recobertas por fibrina amarela.

Lesões se coalescem e formam ulcerações maiores rasas e irregulares.

Gengiva aumentada, eritematosa e dolorosa.

Erosão margem gengival.

Diagnóstico: clínico (biópsia); esfregações citológicas das vesículas rompidas, frequentemente, são usados para detectar os corpos de inclusões virais.

Transmissão: auto inoculação dedos, olhos e áreas genitais.

Tratamento e suporte: analgésico e antitérmico; alimentação líquida e repouso; anestésico tópico (ajuda na alimentação); laserterapia (acelera o processo de cicatrização) — específicos para crianças. Em adultos o tratamento é diferente.

Restringir contatos com lesões ativas para prevenir disseminação e evitar contato com os olhos.

O vírus pode tornar-se adormecido no gânglio trigeminal e, algum período posterior, sofre reativação e causa infecção secundária recorrente —> chamado futuramente de herpes recorrente – causa lesões diferentes.

Primeiro fará o processo de latência no gânglio trigeminal

Herpes Simples HSV1



Herpes recorrente ou herpes labial;

Comum em adultos jovens - .

Etiologia: causado pela reativação do vírus herpes simples.

Fatores desencadeantes: sol, trauma, estresse — redução de imunidade ajuda no aparecimento.

Sinais clínicos:

Inúmeras vesículas, preenchidas por líquido, aparecem comumente no lábio ou ao lado da asa do nariz.

Vesículas rompem formando crostas – 2 dias.

Cicatrização total de 7 a 10 dias.

Sintomatologia: Sinais prodrômicos – 6 a 24 horas antes (dor, ardência, prurido, picotamento, calor, eritema, pontadas).

Diagnóstico: clínico.

Envolvimento intra-oral é incomum (normal em pacientes imunocomprometidos) — Nessa condição, as vesículas se rompem, deixando úlceras dolorosas.

Panarício Herpético (paroníquia herpético)

Lesões em dedos.

Auto-inoculação (“quando passa a mão na região, e passa em outra região”)

Era comum em dentistas antes do uso de luvas.

Podem resultar em parestesia e cicatrizes.

Tratamento (fase prodrômica melhor – início):

Antivirais: tópico ou sistêmico (aciclovir: Zovirax inibe a síntese de DNA viral).

Tópicos - creme: 5x ao dia por 4 dias.

Sistêmico - comprimido: 200 mg 5x ao dia (4 em 4 horas – suprime a dose noturna — 5 dias).

EV (endovenoso) – 250 mg de 8 em 8 horas (5 a 30 dias).

Laserterapia (laser de baixa potência)

SUORTE.

A fase que esta em crosta a transmissão / contágio é menor, mas quando está em vesícula, possui grandes chances de contágio.

Varicela Zoster (Catapora) – HHV3



Infecção primária.

Etiologia: vírus varicela-zoster (VZV ou HHV 3).

Transmissão: disseminação gotículas ou contato direto.

Maioria na idade entre 5 e 9 anos.

Incubação 10 a 21 dias / média de 15 dias.

Sinais clínicos: acometimento de pele e mucosa oral (eritema; vesícula; pústula; úlceras; crosta endurecida).

Lesões orais podem preceder (aparecer antes) as lesões cutâneas.

Sintomatologia: febre, cefaléia, calafrio, mal-estar, faringite, rinite, mialgia.

Complicações como pneumonia e encefalite podem, ocasionalmente, ocorrer.

Torna-se mais grave quando acomete idosos.

Diagnóstico: clínico

Tratamento: sintomático (banhos mornos com bicarbonato ou permanganato de potássio; analgésicos, antipiréticos).

Vacina desde 1974, 98% eficaz.

O vírus pode tornar-se adormecido no gânglio posterior, sofrer reativação, ou seja não é mais a catapora, causando a Herpes Zoster.

Herpes Zoster



Infecção secundária recorrente da catapora.

Etiologia: HHV3 (vírus em latência gânglio espinha dorsal – reativação por imunossupressão, drogas citotóxicas, radiação, tumores malignos, idade avançada, abuso de álcool).

10 a 20% dos indivíduos adultos (risco aumenta com a idade).

Apenas uma recorrência esperada.

Fases prodrômica, aguda e crônica.

Prodrômica: dor intensa, febre, cefaleia – 1 a 4 dias antes.

Aguda: eritema, vesículas, pustulas e crostas.

Crônica: neuralgia pós-herpética – 3 meses.

Diagnóstico: clínico.

Sintomatologia: dor, queimação, ardência perfurante / incomoda / cortante.

Sinais clínicos:

Vesículas se rompem e deixam úlceras dolorosas.

A localização comum inclui o tronco, cabeça e pescoço (envolvimento intra-oral é raro).

Acomete pequenas extensões – trajetos de nervos

Respeita a linha média (reativada num tronco nervoso – principal característica).

Prurido intenso.

Lesões orais - envolvimento do nervo trigêmeo.

A neuralgia pós-herpética é uma complicação em aproximadamente 10% dos pacientes com herpes zoster.

Envolvimento ocular — cegueira.

Tratamento:

Anti-virais em altas doses.

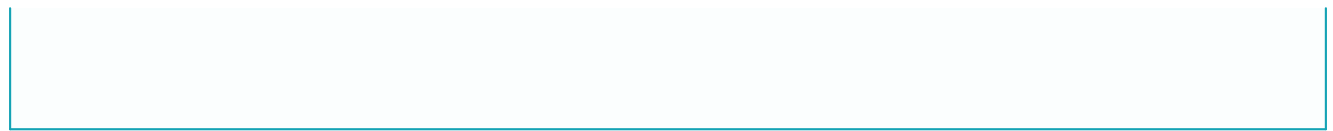
Tratamento de suporte

Laserterapia.

Ø Febre — antipiréticos (que não contenham aspirina) — síndrome de Reye.

Ø Lesões cutâneas secas e limpas para evitar infecção secundária.

ANOTAÇÕES



07

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Virais e Bacterianas (parte 2)

HPV

Papiloma Escamoso



PONTOS-CHAVE

Proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado.

Etiologia: lesão induzida pelo papilomavírus humano (HPV).

Transmissão: desconhecida (sugere-se: contato sexual, não-sexual, objetos contaminados, saliva e leite materno).

Maioria na idade entre 30 e 50 anos.

Baixa virulência e baixa infectividade.

Sinais clínicos:

Nódulo indolor esbranquiçado.

Exofítico com numerosas projeções superficiais digitiformes ("couve flor" ou verrucosa).

Tratamento: biópsia - remoção cirúrgica; prognóstico excelente; raras recidivas.

Verruga vulgar



Proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado.

Etiologia: lesão induzida pelo papilomavírus humano (HPV).

Rara em boca e comum em pele.

Pode se disseminar para outras partes do corpo (autoinoculação).

Transmissão: desconhecida (sugere-se: contato sexual, não-sexual, objetos contaminados, saliva e leite materno).

Adultos e crianças.

Muito contagiosa.

Sinais clínicos: Pápula ou Nódulo indolor o esbranquiçado em mucosa oral. Pápula ou nódulo indolor rosadas, o amareladas ou brancas em pele.

Exofítico com numerosas projeções superficiais digitiformes ("couve flor" ou verrucosa). Tamanho < 5mm. o

Tratamento: Remoção cirúrgica. o

Prognóstico excelente. Raras recidivas. o

Condiloma acuminado



Verruga venérea (maior).

Proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado.

Etiologia: lesão induzida pelo papilomavírus humano (HPV).

Boca, laringe, genitália, região perianal.

Transmissão: DST.

Adolescente e adultos jovens.

Muito contagiosa.

Sinais clínicos:

Nódulo indolor exofítico.

Projeções superficiais curtas e embotadas.

Tamanho 1 a 1,5 cm — maiores que o papiloma.

Tratamento:

Remoção cirúrgica urgente pelo risco de contaminação (é muito rápido).

Prognóstico bom.

ANOTAÇÕES

08

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Úlcera Aftosa Recorrente (Afta)

PONTOS-CHAVE

Uma das patologias mais comuns da mucosa oral.
Prevalência na população de 5% a 66% (média 20%).
Lesão fundamental = **ÚLCERA**.
Destruição da mucosa mediada por linfócitos T.

Causas diversas de caráter imunológico e genético:

Alterações hematológicas;
Distúrbios hormonais e ciclo menstrual;
Ansiedade e estresse;
Tabagismo; Hipersensibilidade a alimentos; o

Estágios:

Premonitório ou prodrômico (24 horas de duração) – sensação de queimação na área em que a úlcera irá se desenvolver (não tem sinais clínicos).

Pré-ulcerativo (18 a 72 horas precedentes à manifestação clínica) -pequena mácula avermelhada, discreto aumento de volume e dor.

Ulcerativo – úlcera bem delimitada e rasa, bastante sintomático, pode aumentar de tamanho nos primeiros 5 dias.

Cicatricial (4 a 35 dias de duração) – sem formação de cicatriz, exceto nos casos maiores.

O tempo de cicatrização de uma UAR é usualmente 3X maior que uma úlcera traumática.

Severidade:

Quadro leve – 1 a 5 episódios anuais.

Quadro moderado – 6 a 11 episódios anuais

Quadro severo – 12 ou mais episódios anuais.

Tipos:

Menor:

Mais comuns (80% dos casos).

Sinais clínicos: Úlcera de bordos rasos (pouca distribuição de tecido conjuntivo), circundada por um halo eritematoso, o fundo é de coloração branco-amarelada ou acizentada.

Pode ser única ou múltiplas / regiões não queratinizadas.

Tem caráter auto-limitante.

Mede, frequentemente, de 3 a 10 mm

Pode se manifestar num período de 7 a 14 dias.

- Sintomatologia: dolorosa.

Diagnóstico: Clínico.

Tratamento: suporte (laserterapia, omcilon ora base).

**Maior:**

Sinais clínicos: é uma variante mais agressiva, com bordos irregulares, com pontos avermelhados no interior da lesão.

O diâmetro pode chegar até 40 mm.

Curso clínico de 2 a 6 semanas / forma cicatriz.

Pode se manifestar múltiplas ou unicamente.

Sintomatologia: dolorosa e infartamento ganglionar.

Diagnóstico: clínico. 1

Tratamento: suporte (laserterapia, omcilon ora base).

**Herpetiforme:**

Maior número de lesões.

Maior número de recidivas.

Sinais clínicos: bordos rasos (quase ao nível da mucosa) e apresenta-se mais rasa que a afta menor.

Apresenta de 1 a 3 mm, e se apresenta de forma numerosa.

- Sintomatologia: dolorosa.

Diagnóstico: clínico.

Tratamento: suporte (laserterapia, omcilon ora base) - período de reparação pode variar de 7 a 10 dias.



Possíveis tratamentos para afta

PALIATIVOS – alívio dos sintomas e reduz a duração.

Corticoidestópicos (omcilonorabase).

Laserterapia.

Própolis 5%.

Casos mais graves= tratamento sistêmico.

ANOTAÇÕES

09

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN)

Sinais clínicos: necrose da papila interdental – papila invertida e edemaciada, fibrinopurulenta e sangramento espontâneo, linfadenopatia, febre, mal estar, odor fétido.

Sintomatologia: dor intensa, gosto metálico.

PONTOS-CHAVE

- Frequente em jovens e adultos jovens.
- Pode levar a periodontite ulcerativa necrosante.
- “Boca de trincheira”.

Etiologia: uma infecção que ocorre principalmente na presença o estresse psicológico. Outros fatores:

- Imunossupressão;
- Tabagismo;
- Trauma local;
- Deficiência nutricional;
- Má higiene oral;
- Sono inadequado;
- Doenças recentes.



Diagnóstico: clínico.

Tratamento:

- Profilaxia profissional cuidadosa;
- Remoção do material necrótico (anestesia);
- Orientação de higiene bucal;
- Irritação com água oxigenada + bochechos com água oxigenada 10 volumes na proporção 1:1;
- Antibioticoterapia (metronidazol 500mg + amoxicilina 500mg);
- Orientação de repouso, ingestão de muito líquido e dieta nutritiva.

Evoluções: periodontite ulcerativa necrosante (perda periodontal).

Caso clínico:

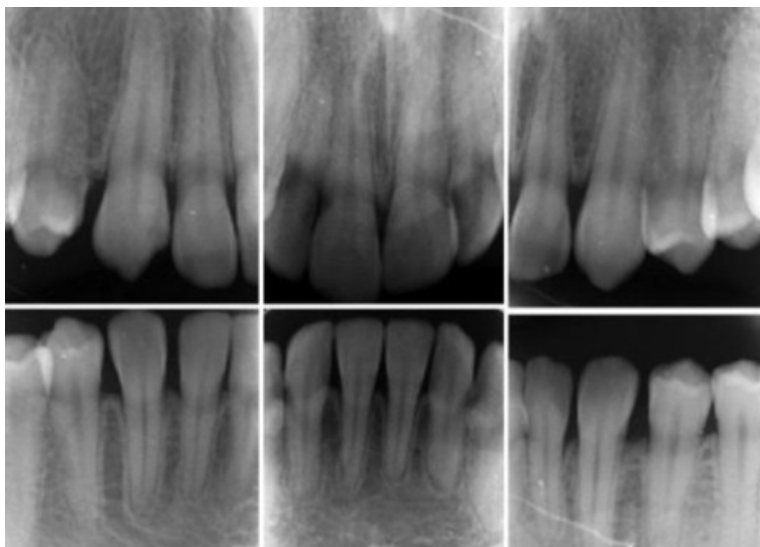
Sexo masculino;
21 anos de idade;
Queixa: dores gengivais há 4 dias;
Febre e dificuldade de comer;
Muito estressado e fazendo dieta;
Sem comorbidades;
Não fazia uso de medicações;

Diagnóstico:

GUN



Não há papilas dentais, e sangramento em algumas áreas.



Aspecto ósseo OK.



Fim do tratamento depois de 7 dias.

ANOTAÇÕES

10

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Neoplasias

NEOPLASIA =

Neo — novo Plasia — formação.

Conceito

Massa anormal de tecido cujo crescimento é descoordenado e excede o crescimento dos tecidos anormais.

Etiologia

Os agentes causadores das neoplasias ainda constituem um mistério. Devido à complexidade de alterações celulares presentes, ainda não se conseguiu o agente agressor.

Possíveis agentes agressores:

PONTOS-CHAVE

Agentes físicos: energia radiante (RX e radiação ultravioleta) e energia térmica.

Agentes químicos: corante e fumo.

Agentes biológicos: virais e bactérias.

Tipos de neoplasias

Neoplasias benignas

Células iguais às do tecido de origem, mas em número extremamente maior, com ou sem componentes inflamatórios.

A nomenclatura das neoplasias benignas segue a regra de se acrescentar o sufixo oma ao nome do tecido de origem.

Lipoma;

Neurilemoma (Schwanoma);

Neurofibroma;

Hemangioma;

Linfangioma;

Leiomioma;

Rabomioma;

Neoplasias malignas

Células diferentes das do epitélio de origem, população constituída por células em proliferação, com diferenciação e em diferenciação proliferativa. Pode ou não apresentar componentes inflamatórios.

Para as neoplasias malignas, utiliza-se a expressão carcinoma para os de origem epitelial e sarcoma para os de origem mesenquimal.

Exceção — Para algumas neoplasias malignas, utiliza-se a regra de nomenclatura das benignas. Ex.: linfomas (origem mesenquimal hematopoiética), melanoma (origem epitelial).

Carcinoma epidermoide;

Fibrossarcoma;

Lipossarcoma;

Angiossarcoma;

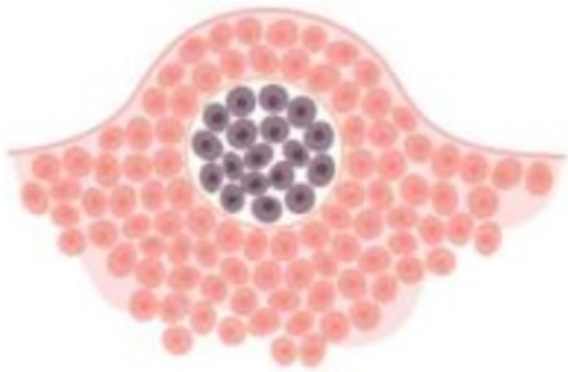
Sarcoma de Kaposi;

Leiomiossarcoma;

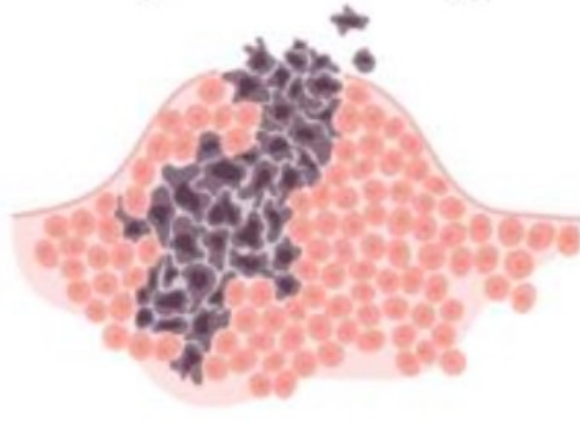
Rabdomiossarcoma;

CRITÉRIOS	BENIGNOS	MALIGNOS
Encapsulação	Presença frequente	Geralmente ausente
Crescimento	Lento, expansivo e bem delimitado	Rápido, infiltrativo com delimitação imprecisa
Morfologia	Reproduz o aspecto do tecido de origem	Carácteres diferentes do tecido de origem
Mitoses	Raras e típicas	Frequentes e atípicas
Antigenicidade	Ausente	Presente, embora geralmente fraca
Metástases	Não ocorrem	Frequentes

Neoplasia benigna



Neoplasia maligna



Carcinoma epidermoide

Sinonímias:

Carcinoma espino-celular (CEC);
Carcinoma de células escamosas;
Carcinoma escamoso;
Câncer bucal;
O álcool e o fumo causam um efeito sinérgico.

Aspectos clínicos:

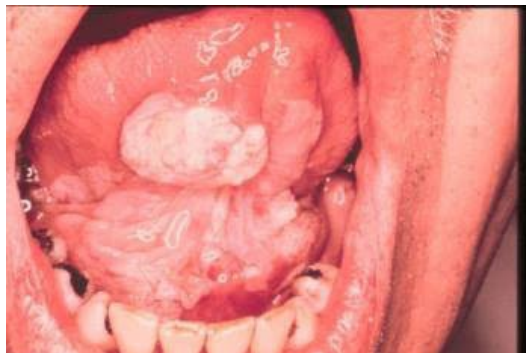
Exofítica: formação de massa fungiforme, papilar, verucosa.

Endofítica: invasiva, crateriforme e ulcerada.

Leucoplásica.

Eritroplásica.

Eritroleucoplásica.



Tratamento

Cirurgia.
Radioterapia.
Quimioterapia.

Lipossarcoma

Sarcoma de tecido mole mais comum (sarcomas de tecidos moles são raros na região oral e maxilofacial, sendo responsáveis por menos de 1% das neoplasias malignas nesta área).

- Aumentos teciduais de crescimento lento.
- Sintomático quando atingem tamanhos consideráveis.
- Mais comum em adultos jovens e crianças.
- Qualquer localização em cabeça e pescoço mais frequente em seios paranasais e nariz.



Tratamento

- Excisão cirúrgica com margem de segurança + radioterapia + quimioterapia.
- Alta taxa de recidiva (50%).
- Sobrevida em 5 anos - 40%.

Sarcoma de Kaposi

- Neoplasia maligna vascular.
- Herpes vírus humano tipo 8.

Tipos clínicos:

1. Clássica;
2. Endêmica (africana).
3. Latrogênica associada à imunossupressão.
4. Relacionado à AIDS.

- Pacientes HIV positivos – redução dos números com a HAART.

Diagnóstico: biópsia.

Tratamento: antiretrovirais e quimioterapia.



Caso clínico:

Paciente sexo masculino.

24 anos.

Leucoderma.

HIV positivo há 2 anos

Queixa: manchas e inchaço no rosto há 8 meses.

Assintomático.

Em uso de antiretrovirais.

CD4+ = 20cels/mm³.

CV = 149.780 cópias/mm³.





Tratamento: HAART e Quimioterapia.

ANOTAÇÕES

11

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Anomalias Dentárias de Desenvolvimento

Aula ministrada pelo Prof. Dr. Renan, em 15 de agosto de 2022, em Universidade Cidade de São Paulo.

CLASSIFICAÇÕES REFERENTES AS ANOMALIAS DENTÁRIAS

ALTERAÇÕES dimensionais, morfológicas, quantitativas, estruturais, topográficas, irruptivas e maxilares.

ALTERAÇÕES DIMENSIONAIS**MACRODONTIA**

Anatomia interna é normal, mas é “enorme” por fora.



Coroa “gigante”.

Limites normais dimensões alteradas.

É dividida em **GENERALIZADA** e **LOCALIZADA**. **GENERALIZADA**: associada ao gigantismo pituitário. **LOCALIZADA**: total ou parcial (coronária/radicular). Normalmente acomete incisivos centrais superiores e terceiros molares inferiores. O paciente possui problema de oclusão (ortodônticos). Alterações no GH.

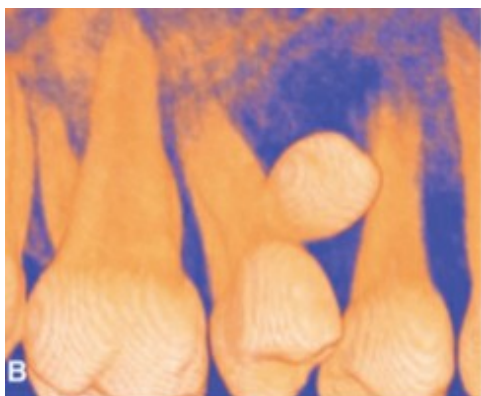
MICRODONTIA



Limites normais e dimensões alteradas. É dividida em **GENERALIZADA E LOCALIZADA**. GENERALIZADA: associada ao nanismo pituitário. LOCALIZADA: total ou parcial (coronária/radicular). Normalmente acomete laterais superiores e terceiros molares superiores. Alterações no GH. O dente possui formato **conóide** (formato de cone).

ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS

GEMINAÇÃO



Coroa dentária com aspecto bífido (duas coroas em um dente só - “duas cabeças em um corpo só”). Sempre serão divergentes, nunca convergentes.

Não à redução do numero de elementos dentários.

Normalmente acomete incisivos superiores e inferiores.

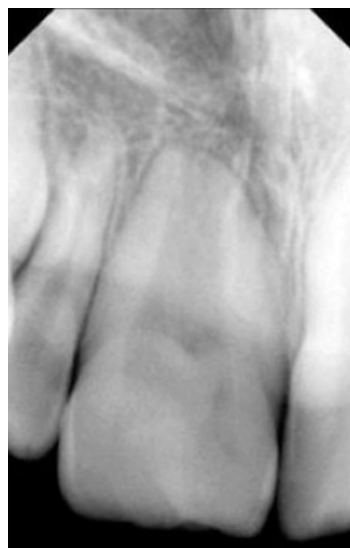
Pode ser, ou não, visível no exame clínico.

Podendo ser feito um tratamento protético, ou realizar a exodontia (mais recomendado), pois pode causar um cisto.

FUSÃO



São dois dentes decíduos que estão se fusionando



Dois centrais fusionados

Tentativa de união de dois germes dentários (**completa** ou **incompleta**).

Há a redução do número de elementos dentários.

Normalmente acomete elementos anteriores inferiores.

Ta faltando elementos dentários = fusão, possui elementos dentários a mais = geminação.

A melhor opção para tratamento, é realizar uma exodontia, e fazer um tratamento com implante.

CONCRESCÊNCIA



Elementos dentários unidos pelo cimento.

Normalmente acomete segundos e terceiros molares.

Para fazer a exodontia, temos que luxar bastante o osso. E para fazer um tratamento endodôntico, é dificultado.

DENTES DE HUTCHINSON

São anomalias congênitas do tipo hipoplásico (diminuição do crescimento) verificadas nos dentes incisivos permanentes e nos molares.

Normalmente associada a sífilis congênita (63%), parece uma amora.

Nos INCISIVOS a porção cervical da coroa é mais larga que a borda incisal (chave de fenda). Podemos realizar uma faceta.



Dentes de Hutchinson

Nos MOLARES a hipoplasia do esmalte e com a superfície oclusal mais estreita do que a normal, dificuldade de oclusão.



Molares em amora

DENS IN DENTE (Dens Invaginatus)



ILS está com necrose e infecção associada a Dens In Dente

Invaginação das estruturas calcificadas pra dentro da câmara pulpar.

Normalmente acomete incisivos centrais e laterais superiores.

Ocorre na odontogênese.

Formação de dentina e esmalte internamente, com aporte sanguíneo.

ANOTAÇÕES

12

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 2)

CÚSPIDE EM GARRA



Projeção em forma de cúspide, a partir do cingulo em direção a borda incisal.

Associada a síndrome de Rubinstein- Taybi.

Normalmente acomete incisivos superiores.

Pode alterar a oclusão do paciente, mas é raro.

Sem tratamento.

TAURODONTIA



A câmara pulpar tem aspecto de "grandona".

Aumento da dimensão oclusoapical da câmara pulpar.

Não aumentamos a proporção, mantemos. Ira crescer todo estranho.

Pode ocorrer em dentições decíduas e permanentes.

Normalmente acomete molares e pré-molares.

RAÍZES FUSIONADAS



Redução do número de raízes. Com ou sem redução do número de canais.

RAÍZES SUPRANUMERÁRIAS



Os elementos possuem taurodontia, e o segundo molar inferior direito possui raízes supranumerárias

Número de raízes superiores ao estabelecido pelo padrão anatômico.

Dentes mais envolvidos: primeiro pré-molar inferior, segundo pré-molar inferior, incisivo central inferior e primeiro molar inferior.

DILACERAÇÃO



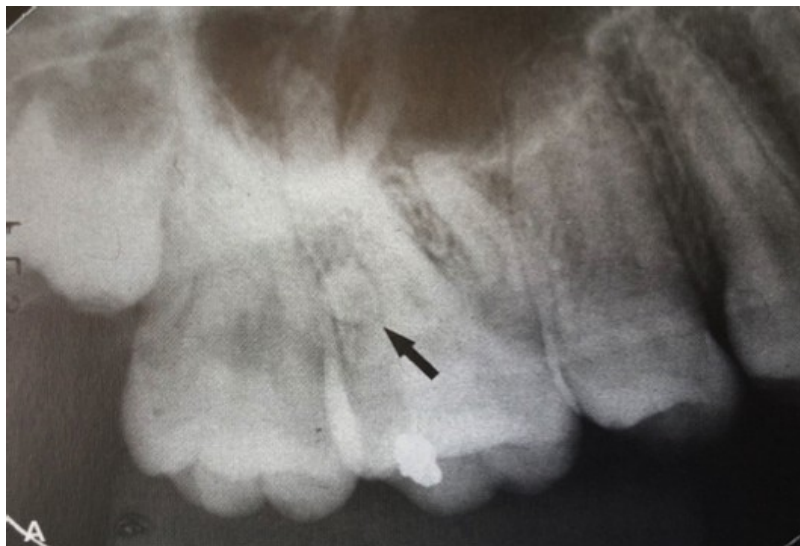
Ocorre alterações da orientação do longo eixo do elemento (podendo ter uma fratura radicular).

Etiologia comumente associada ao traumatismo (quando a criança cai, por exemplo).



Dilaceração coronária

PÉROLA DE ESMALTE



É uma pequena massa de esmalte, localiza usualmente na área e furca.

O ameloblato que deposita o mineral, e há formação de esmalte.

Acomete mais os segundos e os terceiros molares superiores.

Não há tratamento.

NÓDULOS PULPARES

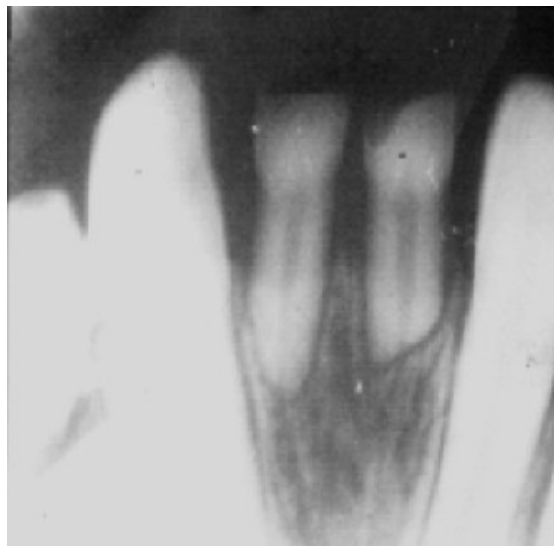


Mineralizações com aspecto arredondado presentes na câmara pulpar.

Quando representam calcificações distrófica, consequentemente à necrose pulpar, não são consideradas verdadeiras anomalias.

ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS

ANODONTIA



Paciente adulto com anodontia parcial. O dente decíduo está retido no arco, por conta da anodontia. Não houve a rizólise.



Anadontia total

Pode ser parcial ou total. A parcial é mais normal, e a total é rara.

“Sem dente”.

Redução do número esperado de dente para cada dentição.

Hipodontia (excluindo o terceiro molar) ocorre em 3% a 10% da população.

A TOTAL é rara na dentição decídua.

Dentes mais comumente ausentes: terceiro molar, segundo pré-molar, incisivo lateral superior e incisivo central inferior.

É rara e está ligada à displasia ectodérmica.

Um ou poucos dentes (hipodontia).

Ausência de vários dentes (oligodontia).

DENTES SUPRANUMERÁRIOS E ACESSÓRIOS

Supranumerário: excede o número esperado de dentes para cada dentição.

Acessórios: quando a forma não lembra a anatomia dos dentes.

EX: MEDIODENS E DISTOMOLAR.

MESIODENTES (mesiodens)



Quando acomete a linha média, entre os centrais.

Normalmente ele está incluído, é raro estar em meio extraoral.

São dentes supranumerários que encontram-se próximo à linha média, mais frequentemente na maxila.



ANOTAÇÕES

13

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 3)**DENTIÇÃO PRÉ-DECÍDUA (dentes natais)**

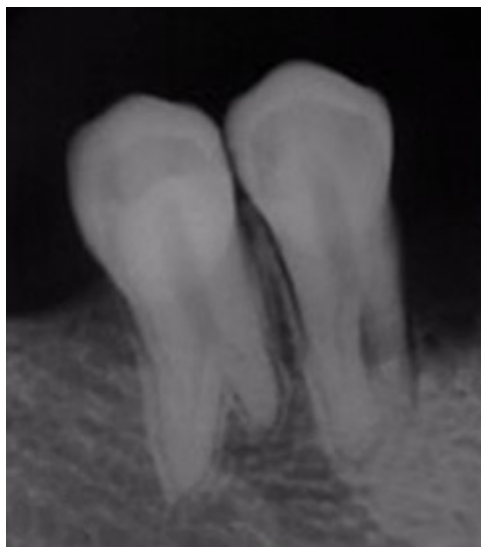
São dentes que precedem a dentição decídua, normalmente na região dos incisivos.

IRÁ TER DENTE DECÍDUO DEPOIS.

São estruturas cronificação, sem raízes (capuz de esmalte e dentina ou apenas esmalte).

Há necessidade de exodontia!

Não devem ser confundidos com dentes deciduos irrompidos precocemente.

RAÍZES SUPRANUMERÁRIAS

Não é uma anomalia rara.

Dentes mais envolvidos: primeiro pré-molar inferior, segundo pré-molar inferior, primeiro molar inferior.

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS

AMELOGÊNESE IMPERFEITA

Alterações de desenvolvimento em estruturas de esmalte.

Anomalia hereditária.

Todos os dentes em ambas as dentições são afetados.

Os dentes decíduos e permanentes, podem ser “tratados” com faceta ou prótese.

As coroas dentarias podem apresentar alteração de cor.

Os pontos de contato com frequência estão abertos.

O esmalte pode estar completamente ausente (aplasia) ou aparecer com uma camada muito fina, principalmente sobre as pontas de cúspide e faces proximais.

É DIVIDIDA EM:

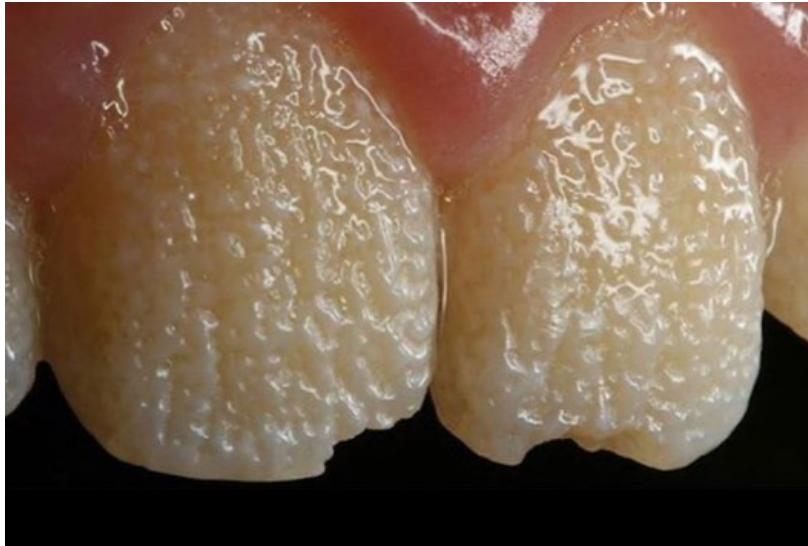
PONTOS-CHAVE

Hipoplasia: formação insuficiente de matriz orgânica).

Hipocalcificado: comprometimento da etapa de calcificação.



Hipomaturado: volume reduzido dos cristais de hidroxiapatita.



HIPOPLASIA DE ESMALTE



O esmalte não se formou totalmente.

Regiões sem cobertura de esmalte ou pequena espessura.

ETIOLOGIA:

- Deficiência nutricional (vitaminas A, C e D).
- Doenças exantemáticas (sarampo, varíola, rubéola).
- Infecções focais e traumatismo local.

Não confunda FLUOROSE, pois ela não possui desgaste no esmalte.



Ocorre no processo de odontogênese, ou seja, se a criança se contaminou com o sarampo, em um desenvolvimento de canino, por exemplo, ela pode ter hipoplasia.

DENTINOGENÊSE IMPERFEITA



Geralmente a coroa apresenta uma translucidez de tom opalescente ou cinzenta.

O esmalte é destacado com facilidade.

O **aspecto radiográfico** caracteriza-se por obliteração total ou parcial das câmaras e condutos pulpaes, resultado da formação contínua de dentina e raízes curtas e cônicas.



Não possui polpa nestes dentes.

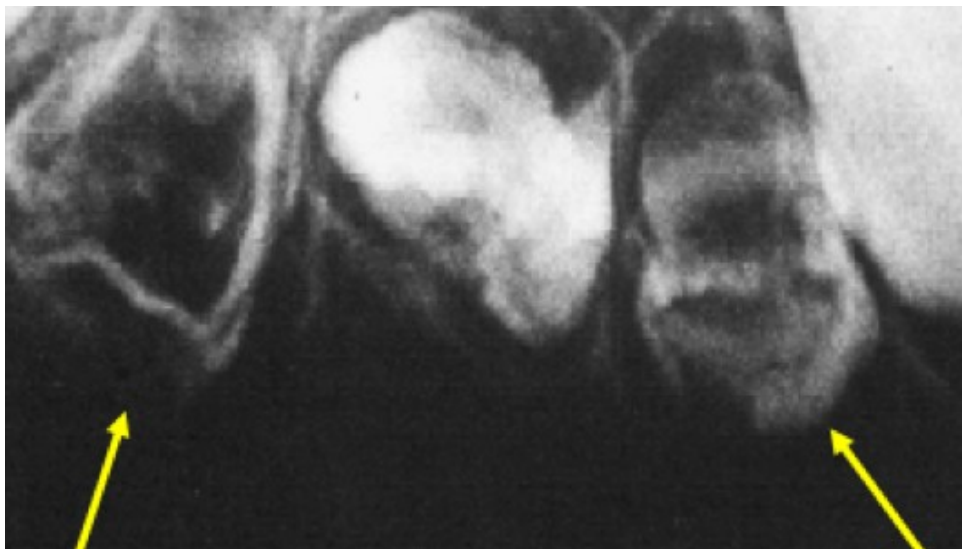
ODONTODISPLASIA REGIONAL

Odontogênese imperfeita (dentes fantasma).

Desorganização estrutural de esmalte e e dentina.

Espaços pulpares amplos, raízes curtas e ápices abertos.

Podem irromper ou não na arcada. Mas em todo caso há necessidade de extração.



ALTERAÇÕES TOPOGRÁFICAS

DENTE NÃO IRROMPIDO



Possui uma barreira física na trajetória de erupção.

Trajetória anormal de erupção devido a mudança de posição do germe dentário.

Retenção do dente predecessor.

Ausência de espaço no arco dentário.

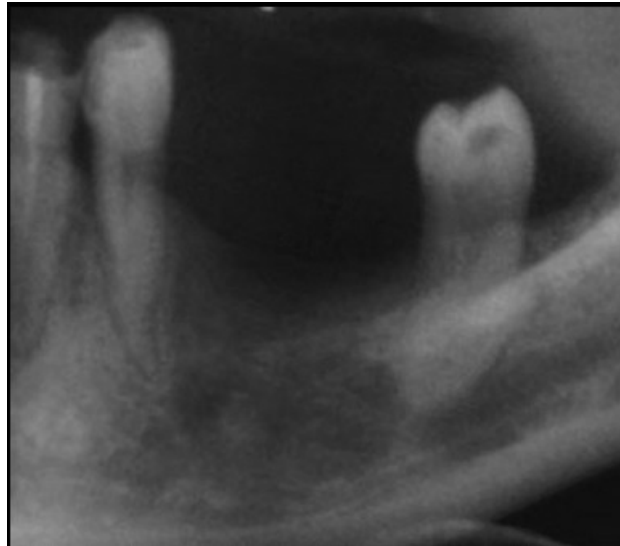
Os dentes mais envolvidos são: Terceiros molares (inferiores e superiores), canino superior e pré-molares.

TRANSPOSIÇÃO



O paciente possui transposição, o canino está depois do pré-molar. Posições invertidas na arcada. Pode estar associado a agenesia. Mais comum de acontecer entre canino e pré-molar. Tratamento: ortodontia ou prótese.

MIGRAÇÃO



É a mudança na posição de um dente por falta de contato interproximal. É comum nos segundos pré-molares inferiores após a perda precoce do primeiro molar inferior.

ANOTAÇÕES

14

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Anomalias Dentárias de Desenvolvimento (parte 4)

EXTRUSÃO DENTÁRIA



É a falta de contato do antagonista.

GIROVERSÃO



Dente apinhado e girovertido Frequentemente observada em incisivos e pré-molares. Pode estar associada a ausência de dentes adjacentes.

ECTOPIA



É a presença de um dente em região distante ou diferente da origem.

“Quando vem em um lugar muito errado”.

ALTERAÇÕES IRRUPTIVAS

RETENÇÃO DENTÁRIA



Elemento decíduo retido no arco (pode ou não apresentar rizólise).

Elemento normalmente apresenta infraoclusão (não está tendo contato com o antagonista).

Possuímos duas alterações de irrupção, a PREMATURA (o dente “nasce” antes da hora) e RETARDADA (dente “nasce” depois da hora). E estas alterações não possuem problema, é normal.

ANOMALIAS MAXILARES

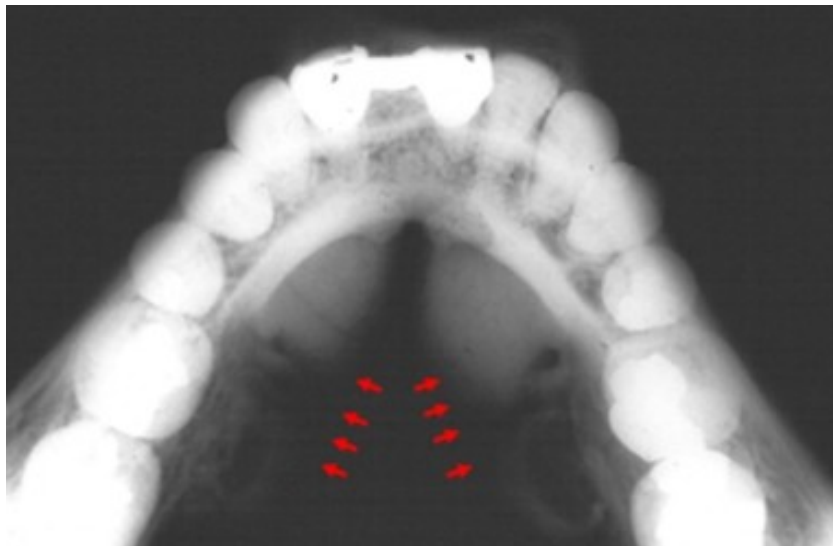
FENDAS PALATINAS



É a falta de fusão dos dois processos palatinos entre si ou destes com o processo fronto-nasal.

Pode ser uni ou bi-lateral, completa ou parcial (fator hereditário).

TORUS



São exostoses ósseas que ocorrem na superfície perióstraco a maxila ou mandíbula em locais definidos.

Clinicamente são elevações planas ou globuladas, recobertas por mucosa normal e duras à palpação.

RADIOGRAFICAMENTE apresenta uma radiopacidade maior que a do osso adjacente.

Dividem-se em TORUS PALATINO e TORUS MANDIBULAR

O palatino é frequentemente encontrado na linha mediana do palato. Já o mandibular é comumente encontrado na face lingual e nas áreas de dentes pré-molares e molares.

ANOTAÇÕES

15

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões do Órgão Dentário

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Renan Lucio, em 08 de agosto de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo.

Relembrando: nosso órgão dentário é dividido em: ESMALTE; DENTINA; CÂMARA PULPAR; CANAIS RADICULARES e CEMENTO.

No estudo radiográfico do órgão dentário, é possível dividir em 2: **1. Coroa; 2. Raiz;**

Todas as imagens são divididas em:

PONTOS-CHAVE

Radiolúcidas (escuro);
Radiopaco (claro);
Traumatismos dentais;

A interpretação baseia-se nas diferentes tonalidades de cinza.

IMAGENS RADIOLÚCIDAS**Cárie - Lesões cariosas**

A cárie é uma doença infecciosa, e uma das mais comuns.

A cárie é um processo de desmineralização do dente, uma doença multifatorial.

Esse processo acontece por conta da bactéria *S. Mutans Sp* + estreptococos, mas isso não diz que você há cáries nos dentes, e para isso precisamos ter o carboidrato na boca, produzindo o ácido lático, desmineralizando o dente (ou seja, para acontecer a cárie, precisamos tirar o mineral do dente).

Se temos menos mineral, possibilita uma maior passagem de radiação, ou seja, irá sensibilizar o fio, e irá ficar radiolúcido, porém a imagem não tem limites definidos e não é homogêneo.

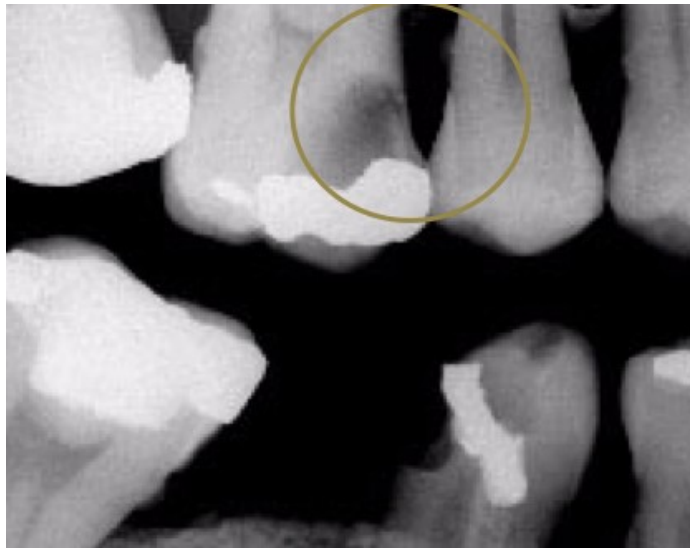
Na radiografia iremos ver a cárie de “desfazendo”, “sumindo”, pois ela não tem limites definidos.

SEM LIMITES DEFINIDOS, NÃO É HOMOGÊNEO E É RADIOLÚCIDO.

A cárie é sempre maior do que vemos na radiografia.

A cárie pode acontecer por conta de um processo de infiltração da restauração, ou seja, meu sistema adesivo falhou, ocorreu GAP.

A **região interproximal** é um problema, podemos cobrir alguma lesão, caso for feita a técnica errada, assim podemos sobrepor algumas estruturas.



Paciente apresenta restaurações por amálgama (muito radiolúcida). A restauração do dente 16 está infiltrada.

As **cáries interproximais** formam um duplo triângulo, isso ocorre pois no esmalte temos uma grande quantidade de mineral.



Duplo triângulo na região mesial do dente 36



No dente 14 temos um suposto diagnóstico de uma lesão cariosa, conseguimos analisar que a extensão da lesão está próximo a polpa do dente, MAS TEMOS QUE LEMBRAR QUE A IMAGEM DISTORCE, ENTÃO COM CERTEZA NO EXAME CLÍNICO, JÁ CHEGOU NA POLPA.



DIFERENÇA ENTRE CÁRIE E INFILTRAÇÃO = a infiltração é radiolúcida, bem preta, ou seja nestas regiões há formação de GAP = infiltrações.

VELAMENTO CERVICAL

O velamento NÃO É UMA LESÃO, ela ocorre quando há uma diferença de radiopacidade.

A coroa é recoberta por esmalte (esmalte + radiopaco) e a raiz é recoberta por osso alveolar (maior espessura), e a constrição radicular.

A região entre a coroa e a raiz (colo ou cervical) acaba com uma imagem mais radiolúcida que pode parecer uma lesão proximal.

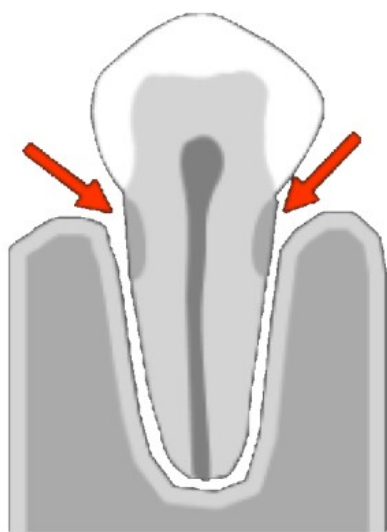


O VELAMENTO CERVICAL sempre **vai ocorrer abaixo do JEC (junção esmalte cimento)**.

O velamento vai ocorrer na JEC, pois abaixo do ponto de contato acumula placa bacteriana, e a lesão cariosa vai ocorrer aí.

O velamento É UMA SOMBRA!

Para diagnosticar um velamento é só imaginar um 8, pois quando saímos da coroa em direção a raiz, temos uma reentrância, local onde temos menos mineral. ↓



No dente 46 podemos ver o “famoso pontinho”, mas a cárie está com uma extensão bem grande.

CÁRIES EM CEMENTO / CÁRIE RADICULAR



Cárie radicular no dente 46. Não temos JEC, pois é uma coroa protética, então carie pode ser nesta região.



Cárie com extensão na polpa no dente 46. Não temos JEC, pois não há esmalte.

RESTAURAÇÕES COM RESINA SEM CARGA

Adesivos e vernizes por serem compostos de materiais com baixo número anatômico, também podem ser interpretado como cáries recorrentes.

O uso de resina sem carga também pode ser interpretado como imagens radiolúcidas sugestivas de cárie.

ANOTAÇÕES

16

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões do Órgão Dentário (parte 2)

Porém há limites, e é homogênea, então não é cárie. A resina é sem carga, por isso é radiolúcida



No dente 21, conseguimos analisar a resina sem carga.

MATERIAL DE FORRAMENTO

Na presença de imagem radiopaca de forramento, não será interpretada como imagem radiolúcida na coroa.

Materiais de forramento são: CIV (ionômero de vidro) ou HC (hidróxido de cálcio). Eles ficam mais radiopacos que a resina.



Dente 11 com material de forramento + resina

Lesões NÃO cariosas

A desmineralização não causada pelo estreptococos.

Temos a:

PONTOS-CHAVE

Abrasão;

Erosão;

Atrição;

EROSÃO

É uma dissolução química progressiva dos tecidos minerais. Isso ocorre devido ao contínuo uso de bebidas e medicamentos ÁCIDOS.

Para o TRATAMENTO destas erosões é necessário retirar a CAUSA, e fazer uma overlay = coroa total (em casos de oclusais ↓).



Quando as lesões de EROSÃO, ocorrem na PALATINA, vemos uma mancha escura = dentina terciária em formação. Na maioria das vezes está associada a bulimia nervosa, pacientes bulímicos ("fazem força para vomitar"). E o tratamento é restaurador e indicar o paciente para um médico. ↓



Biocorrosão



Imagem radiolúcida, com limites não homogêneos. Conseguimos ver na região de ICS e ILS não é um diagnóstico de cárie, porque a lesão é muito extensa na borda incisal.

ABRASÃO

Pode ser causada por:

Escovação traumática - a *pasta de dente (dentifrício)*, é abrasiva;

Má adaptação de grampos de próteses parciais removíveis (PPR);

Hábitos parafuncionais, como apartamento ou bruxismo + atrição.

Roer as unhas = onicofagia; ponta de canetas.

OBS: é normal aparecer este tipo de abrasão em costureiras, pelo hábito de segurar o alfinete com a boca.



As lesões por abrasão, na radiografia, aparecem em formato de MEIA LUA.

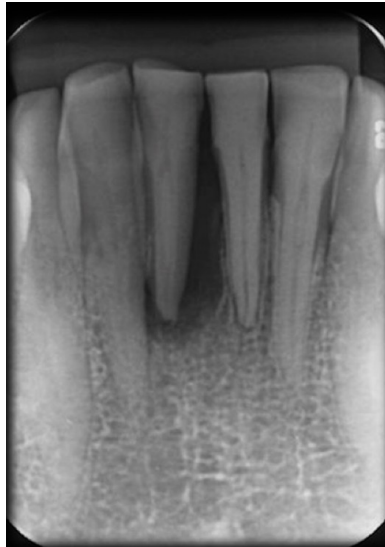
ATRIÇÃO

Pode ser causada por:

Contatos e apertamentos;

É possível notar a presença de **atresia pulpar** = deposição de mineral para a proteção do dente, isso ocorre quando há diminuição da polpa;

OBS: os dentes só se encostam quando estamos comendo. Em pacientes normais, os dentes se encostam por apenas 7 minutos. Já em pacientes que possuem apertamento 30/40 minutos.



Paciente diagnosticado com bruxismo / apertamento. Na perapical notamos, desgaste nos dentes II, necrose pulpar e reabsorção óssea.

Quando o paciente é diagnosticado com bruxismo / apertamento, há exposição do esmalte e da dentina.

REABSORÇÃO RADICULAR

Possuímos 3:

1. Reabsorção radicular fisiológica (rizólise - RIZO = raiz e LISE = destruição).
2. Reabsorção radicular externa.
3. Reabsorção radicular interna.

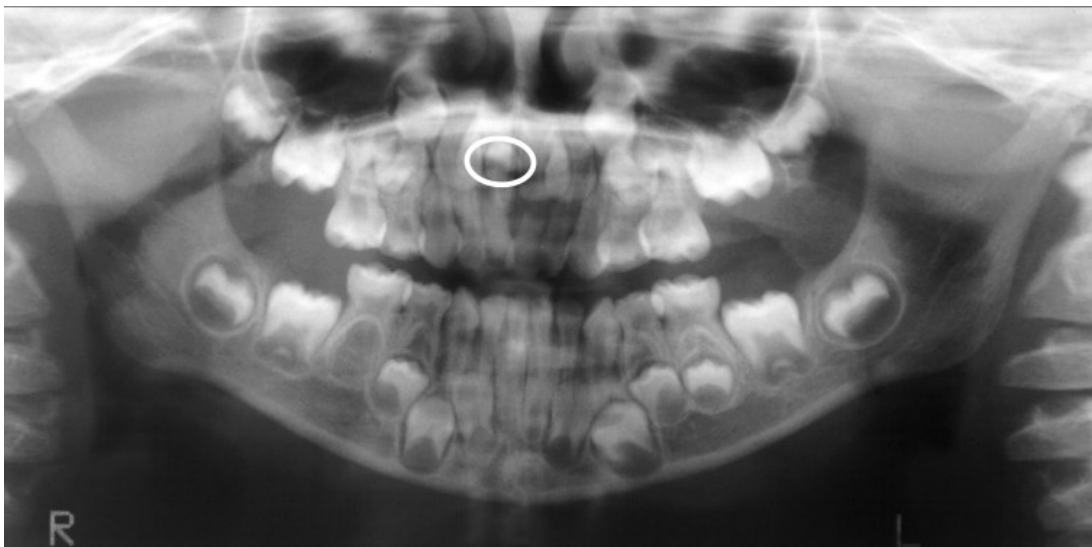
REABSORÇÃO RADICULAR FISIOLÓGICA (RIZÓLISE)

Ele é um processo fisiológico, que precede a exfoliação dos dentes DECÍDUOS, para dar lugar aos dentes PERMANENTES. Com isso ocorre reabsorção de raiz.

OBS: quando cai um dente de leite, não sangra, pois o contato é EPITÉLIO + EPITÉLIO, não há exposição do tecido conjuntivo.



Nesta periapical, notamos uma dentição mista. O paciente não possui o Lateral Superior Permanente, caso de anadontia.



Este paciente está em fase de dentição mista, e pela panorâmica vemos que ele possui um supranumerário, o ICS direito.

REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA

Processo de reabsorção inflamatória progressiva OU resposta a um processo infeccioso/traumático.

O processo traumático é um contato prematuro ou ortodontia. Ele pode ser de ALTA ou BAIXA intensidade.

ANOTAÇÕES

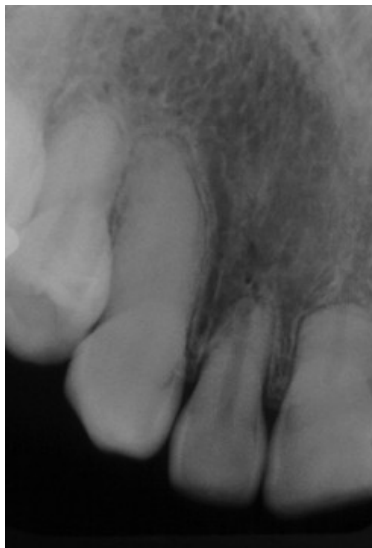
17

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões do Órgão Dentário (parte 3)

OBS: Na ortodontia, por exemplo, é um contato de baixa intensidade, assim que acabamos o tratamento ocorre o arredondamento apical. Isso porque o osteoclasto não sabe diferenciar dente de osso, e então ele reabsorve mineral.

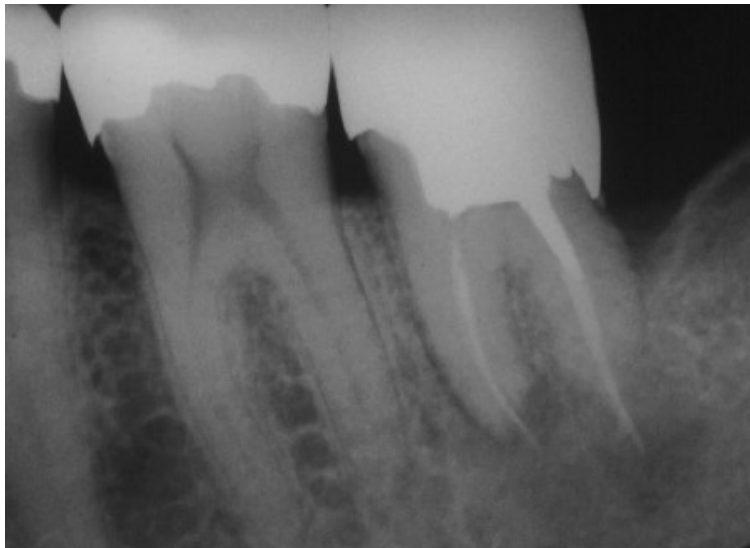
E na maioria das vezes o paciente é assintomático.



Reabsorção de mais da metade da raiz do ILS direito.



Arredondamento de raízes (ICS's)



Paciente se submeteu a tratamento ortodôntico, houve uma infecção por conta da endodontia, e houve reabsorção óssea. Temos que reparar que o cone de guta-percha ficou, ele não é reabsorvido.

REABSORÇÃO RADICULAR INTERNA

Pode ser traumática ou infecciosa. Quando ocorre infecção, os osteoclastos irão agir, tendo uma reabsorção na polpa, começando pela parte interna do conduto radicular.

É uma reabsorção inflamatória de progressão rápida (interno na polpa).

Os pacientes, na maioria, são assintomáticos.

O tratamento destas lesões é endodôntico.



Quando está reabsorção, acaba chegando em tecido ósseo, não consegue diferenciar dente de osso. Quando isso ocorre o paciente se submete a uma cirurgia de enxertia óssea + colocação de implantes.

IMAGENS RADIOPACAS DA COROA E RAIZ

PONTOS-CHAVE

- Dentina Terciária (reparadora);
- Nódulos pulpare;
- Esclerose pulpar;
- Hipercementose.

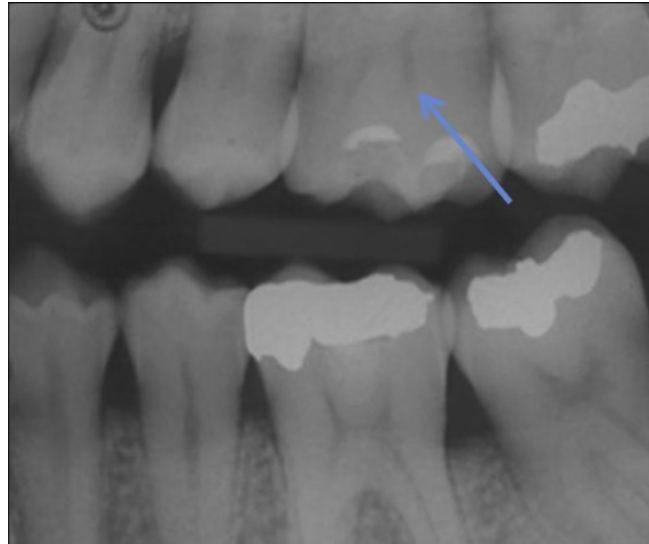
DENTINA TERCIÁRIA

A dentina terciária não tem um padrão correto de crescimento, os seus cristais são desorganizados, por isso quando passa a radiação, mostra-se na imagem como escuro (radiolúcido).

É um estímulo agressivo de baixa intensidade, traumatismo ou patologia.

Há a redução da câmara pulpar e atresia dos canais radiculares de forma total ou parcial.

O seu aspecto radiográfico é mais radiopaco em comparação com o tecido pulpar.



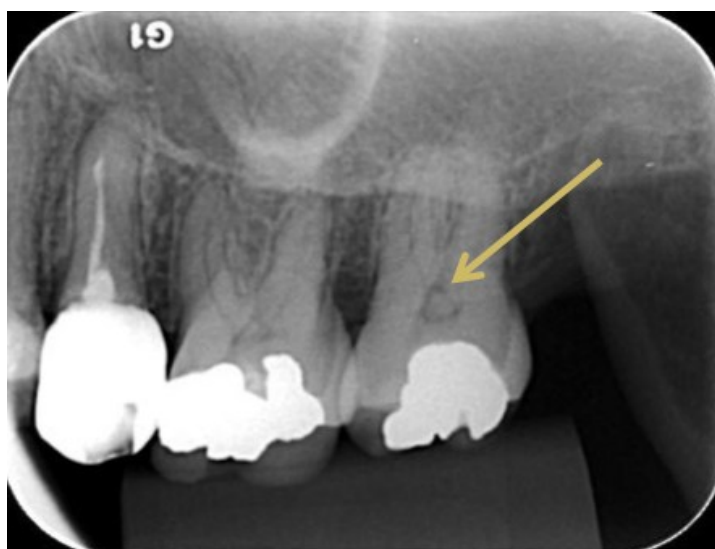
NÓDULOS PULPARES

São calcificações presentes na câmara pulpar de formato arredondado ou oval.

Sua etiologia é até então desconhecida, mas cientistas têm hipóteses de um processo inflamatório.

É uma lesão que não há necessidade de tratamento. Porém pode retirar estas “bolinhas” com um explorador.

O aspecto radiográfico é mais radiopaco e comparação com o tecido pulpar (“bolinhas dentro da câmara pulpar”).



ESCLEROSE PULPAR

Este tipo de lesão compromete a polpa toda, e não é em formato de “bolinha”.

São calcificações presentes na polpa, sem padrões de forma definido.

Não há como diferenciar a fase preliminar dos nódulos pulpare com a esclerose radiograficamente.



HIPERCEMENTOSE

Pode acometer uma ou todas as raízes do mesmo dente.

Este tipo de lesão não precisa de tratamento. Somente em casos que vamos realizar a exodontia de um dente que possui hipercementose, neste caso iremos realizar uma osteotomia, pois se não for realizado a chance de fratura é alta.

A ETIOLOGIA mais provável é uma produção de cemento para conter extrusão dentária (resulta de um deslocamento axial do dente, apenas de forma parcial, para fora do alvéolo resultando na maioria das vezes em necrose pulpar), resultando em uma inflamação apical.



O diâmetro é maior no ápice

INTERPRETAÇÃO DAS LESÕES NO ÓRGÃO DENTÁRIO

São classificadas conforme a localização, forma e estruturas envolvidas.

Trinca coronária (não há separação das partes).

Fratura coronária.

Fratura coronoradicular.

Fratura radicular.

TRINCA CORONÁRIA

“Vejo um traço, mas na radiografia não vejo nada”.

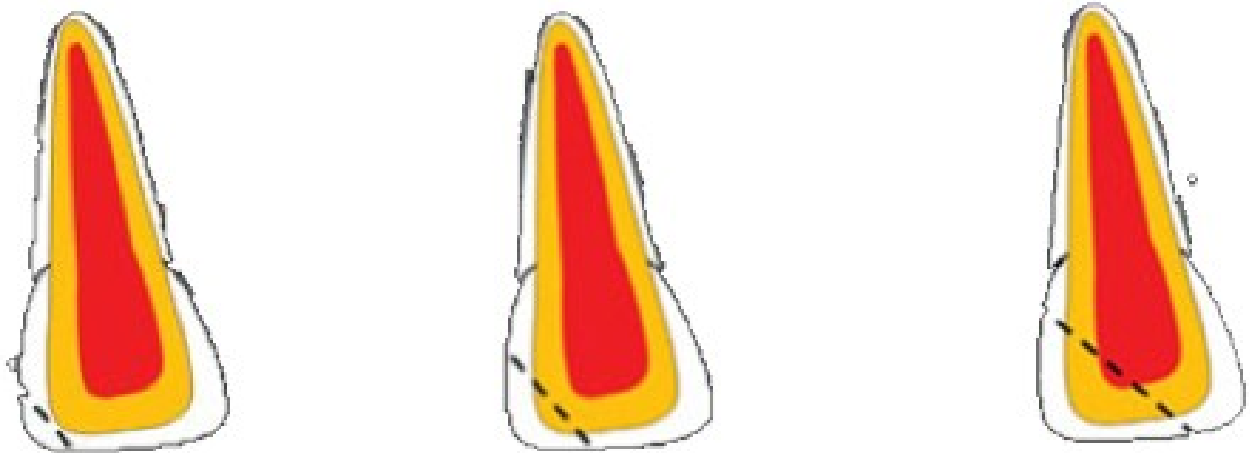
É uma fratura incompleta da coroa dental, sem perda de estrutura dentária, APENAS detectável ao exame clínico.

FRATURA CORONÁRIA

É a fratura completa da coroa dental COM perda da estrutura dentária.

Quando **não há** exposição pulpar (ESMALTE + DENTINA), o tratamento é RESTAURADOR.

Quando **há** exposição pulpar (ESMALTE + POLPA), fazemos revitalização (quando o paciente é jovem) e endodontia, pois há infecção.



ANOTAÇÕES

18

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

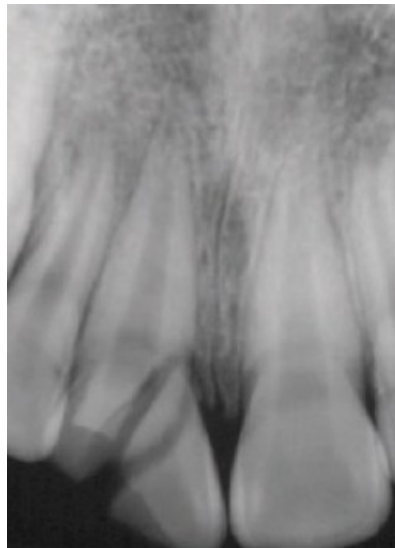
Lesões do Órgão Dentário (parte 4)



Sem envolvimento



Radiograficamente SEM envolvimento



Radiograficamente COM envolvimento

FRATURA CORONORADICULAR

Fratura de coroa e/ou raíze envolvendo esmalte, dentina e cimento, pode HAVER ou NÃO EXPOSIÇÃO PULPAR.

Maior incidência/frequência no sentido inciso-apical.



Este tipo de fratura é mais reta. Onde há tons de cinza no elemento 14, é infiltração de saliva.

Ocorre em consequência da manipulação incorreta do canal radicular.



Radiograficamente é uma imagem raiolúcida (na porção radicular, geralmente acompanhada de uma rarefação óssea, no tecido ósseo adjacente).

FRATURA RADICULAR

É a fratura do cimento e da dentina envolvendo tecido pulpar.

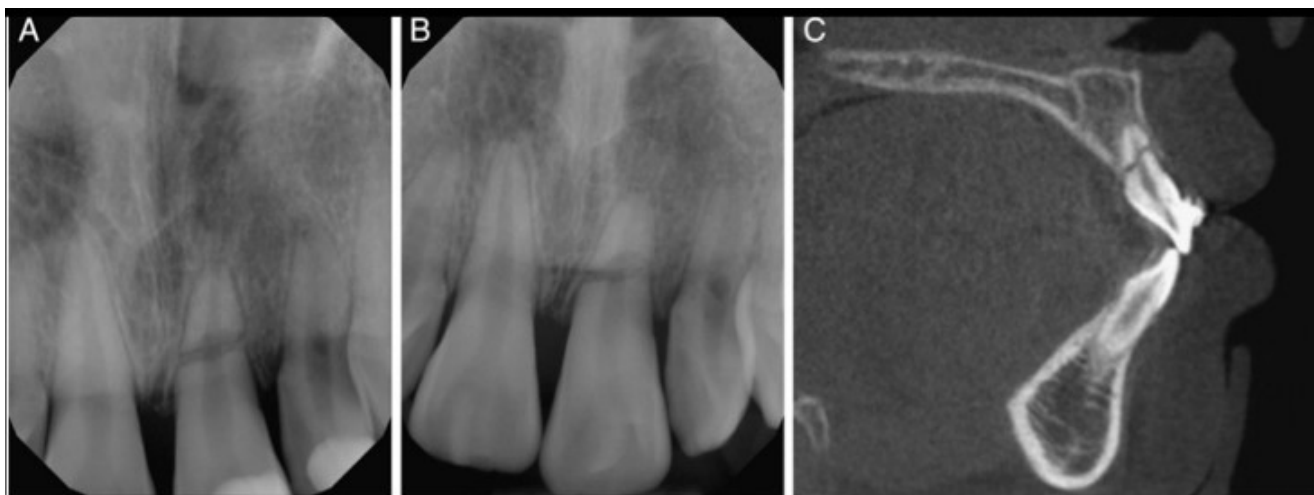
Podemos ter:

PONTOS-CHAVE

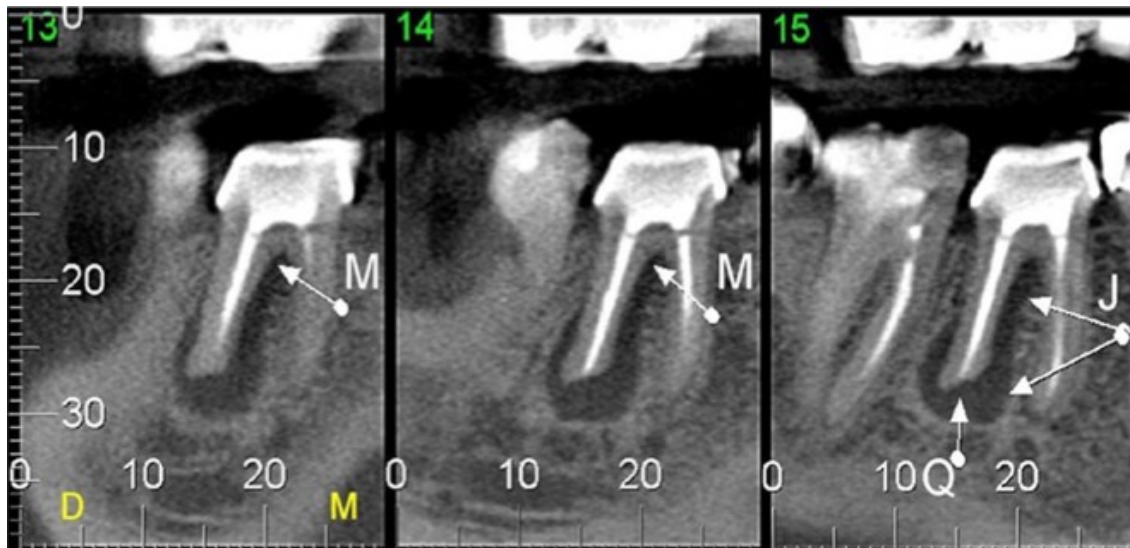
Fratura radicular cervical, colo do dente.

Fratura de terço médio.

Fratura do terço apical.



FRATURA DE TERÇO MÉDIO, na região do dente 21, com reabsorção óssea, ou seja “está preso por tecido mole”).



FRATURA RADICULAR ENVOLVENDO A REGIÃO DE FURCA = CERVICAL

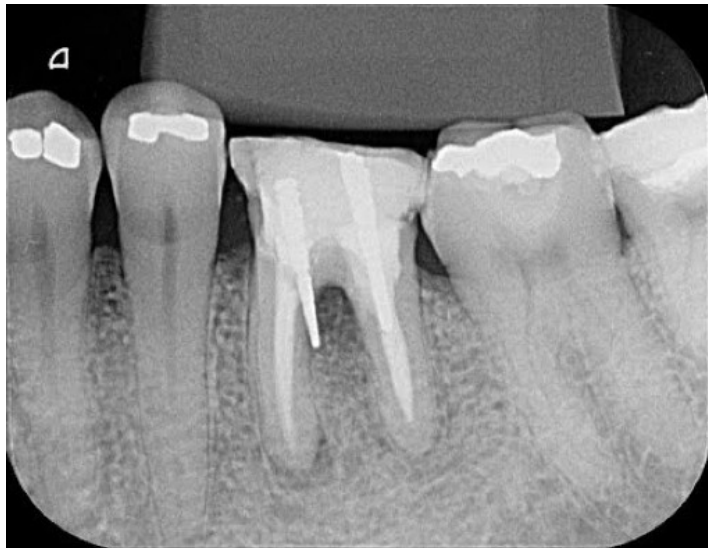
TREPANAÇÃO OU PERFURAÇÃO

Ocorre quando não segue o canal radicular na endodontia.

Durante o tratamento endodôntico ou protético, podem ocorrer desvios no preparo (iatrogenia).



Trepanação



Trepanação

ANOTAÇÕES

19

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões do Periodonto e do Periápice

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Renan, em 22 de agosto de 2022, em Universidade Cidade De São Paulo.

RADIOGRAFIA PANORÂMICA

Apresenta limitações de detalhes para a avaliação de algumas lesões.

Nome que se da: **Ortopantomografia**.

TÉCNICA RADIOGRÁFICA INTRABUCAL DO PARALELISMO

O filme deve ficar paralelo ao longo eixo do dente e o feixe de raios X deve incidir perpendicularmente ao dente e ao filme.

Para saber mais sobre a técnica, leia a apostila de Diagnóstico Integrado 1.

A técnica fazemos com os Posicionadores, e as vezes podemos fazer sem ele, técnica de bisettriz, mas apenas quando a pessoa tem limitação de abertura de boca e alguns casos de endodontia.

TÉCNICA RADIOGRÁFICA INTRABUCAL INTERPROXIMAL

Fazemos a técnica interproximal, para analisar o periodonto.

Vamos avaliar perda óssea e cálculos dentários/salivar.

LIMITAÇÕES NAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS**PONTOS-CHAVE**

Sobreposição de imagens (exames bidimensionais).

Não sugere o número de cortiços envolvidas, nem a extensão do defeito ósseo.

Subquantificação da gravidade o defeito ósseo (temos que ter pelo menos 50% de perda mineral). É uma distorção, pois colocamos uma imagem tridimensional em um plano.

Impossibilidade de acusar alterações restritas aos tecidos moles.

INTERPRETAÇÃO RADIOGRÁFICA

Vamos avaliar tecidos duros:

Avaliação da lâmina dura e cristas ósseas.

A perda da lâmina dura é o primeiro sinal de alteração na câmara pulpar.

Trabeculado ósseo.

Presença de cálculo salivar, lesões cariosas.

O cálculo salivar possui um biofilme, que se forma em cima do cálculo.

Restaurações com falha ou excesso de material.

Ausência de elementos dentais.

Alterações	Clínicas	Radiográficas
Reab. óssea	■	■
Mobilidade	■	■

Alterações	Clínicas	Radiográficas
Presença de bolsas periodontais	■	■
Cálculo salivar	■	■
Retração gengival	■	■

LESÕES DO PERIODONTO

“Doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, causada por microrganismos específicos ou grupos de microrganismos específicos, resultando em uma destruição progressiva do ligamento periodontal e osso alveolar, com formação de bolsa, retração gengival, ou ambas”. Carranza, 2004

As características radiográficas variam conforme o tempo de progressão da lesão.

1. Cálculo Salivar;
2. Reabsorção horizontal da crista óssea alveolar;
3. Reabsorção vertical da crista óssea alveolar;
4. Lesão de furca;

CÁLCULO SALIVAR - BIOFILME CALCIFICADO

Os cálculos são massas duras, podendo ser redondos, ovais ou cilíndricos, predominantemente de coloração amarela e geralmente solitários.



No elemento 15, 2PMS, conseguimos ver uma lesão de furca, os cálculos salivares



Analizamos uma reabsorção óssea, tábua óssea, além de cálculos salivares nos elementos 45 e 46.

Na presença de cálculos salivares e a perda da tábua óssea (reabsorção a crista óssea alveolar), ela fica LOCALIZADA abaixo da JEC, +/- 2 a 3mm = espaço biológico

Para entender mais sobre Espaço Biológico veja os resumos de Periodontia Pré Clínica.

REABSORÇÃO DA CRISTA ÓSSEA

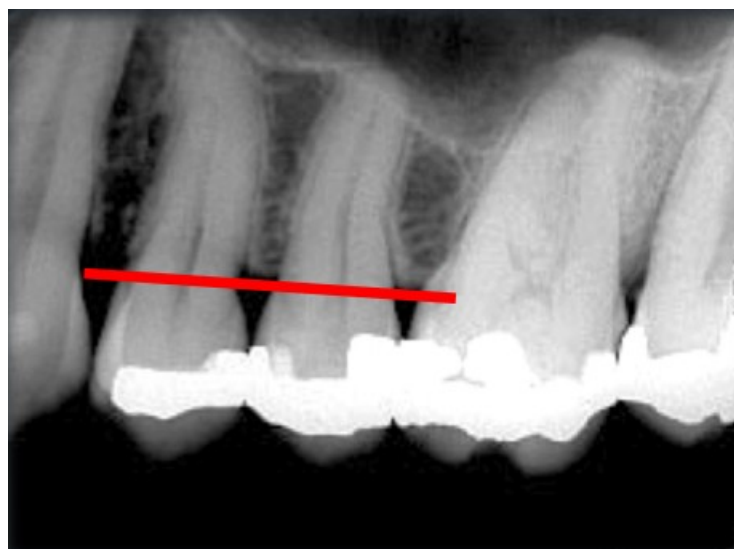
A progressão desse processo inflamatório bastante avançado pode determinar ao final uma reabsorção da crista óssea.

Podemos classificar uma reabsorção de duas formas:

1. Horizontal
2. Vertical

Para poder classificar temos que encontrar a JEC. Se a distancia da crista até a JEC for **DIFERENTE** será **VERTICAL**. Já se a distância/mesma altura for **IGUAL** será **HORIZONTAL**.

Quando há falta de um remanescente (dente) do osso alveolar, não classificamos como VERTICAL e HORIZONTAL.



Reabsorção Horizontal Da Crista Óssea Alveolar



Reabsorção Vertical Da Crista Óssea Alveolar. Está reabsorção é bem localizada (entre o canino e o lateral), então podemos dizer que a sua origem foi traumática, como por exemplo mal oclusão.

Independente se a reabsorção for vertical ou horizontal, traumática ou não, TERÁ ACÚMULO DE BIOFILME, e na periodontia, o indicado é realizar uma raspagem.

Veja mais sobre em Periodontia Pré Clínica

LESÕES DE FURCA = REABSORÇÃO DO SEPTO INTRARRADICULAR



As regiões de bifurcações ou trifurcações podem ser atingidas pelos mesmos processo inflamatório.

É possível realizar o diagnóstico desse tipo de lesões a partir do exame de sondagem clínica e também com o auxílio de imagens radiográficas.

Normalmente as lesões de furca, acontecem devido a contato prematuro e a reabsorção vertical.

TRATAMENTO: raspagem; enxerto ósseo e podemos realizar a TUNELIZAÇÃO, iremos aumentar o espaço, para que assim o paciente consiga higienizar.

LESÕES DO PERIÁPICE

Desenvolvem-se a partir da inflamação direta da polpa ou do periodonto. Podendo ser reversível ou não, causando uma necrose.

A necrose que decorre da inflamação pulpar pode originar-se de uma injúria física ou infecciosa. Podendo ser uma lesão crônica de perda óssea. Caso for uma lesão aguda, o paciente sentirá muita dor, levando a um abscesso.

As características radiográficas variam conforme o tempo de progressão da lesão.

ANOTAÇÕES

20

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões do Periodonto e do Periápice (parte 2)

1. Periodontite Apical Aguda;
2. Abscesso periapical;
3. Traçado de Fístula;
4. Granuloma;
5. Cisto Periapical;
6. Lesão Endo - Perio.

PERIODONTITE APICAL AGUDA

Estágio inicial do processo de inflamação do ligamento periodontal (trauma ou infecção), edema, vermelhidão e dor.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: não conseguimos ver a perda da lâmina dura, mas sim o ligeiro aumento do espaço do ligamento periodontal apical. Não tendo evidências radiográficas.

Normalmente o paciente chega com dor, lesão aguda.

ABCESSO PERIAPICAL → agudas e crônicas ↓

ABCESSO PERIAPICAL AGUDO

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Radiograficamente apresenta aumento do espaço pericementário/ rompimento da lâmina dura.

Não tratando o abscesso agudo, o paciente se dá a uma lesão crônica, podendo ter dor depois de muitos anos.

Nestes casos o paciente apresenta dor.



Abcesso Periapical Agudo

ABCESSO PERIAPICAL CRÔNICO

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Área radiolúcida de bordas mal definidas e difusas, com tamanho e formas variáveis, localizada na região periapical de dentes sem vitalidade pulpar. (Assintomático).

Clinicamente observa-se a presença de fístula (via de drenagem da secreção purulenta produzida por essa patologia). Ela vai e volta.

Este tipo de abscesso (crônico) será ROPD = rarefacção óssea periapical.



Fazemos um **traçado de fístula** com cone de guta percha, para termos noção da origem da fístula.



GRANULOMA

Granulomatose será ROPC = rarefacção óssea periapical circunscrita.

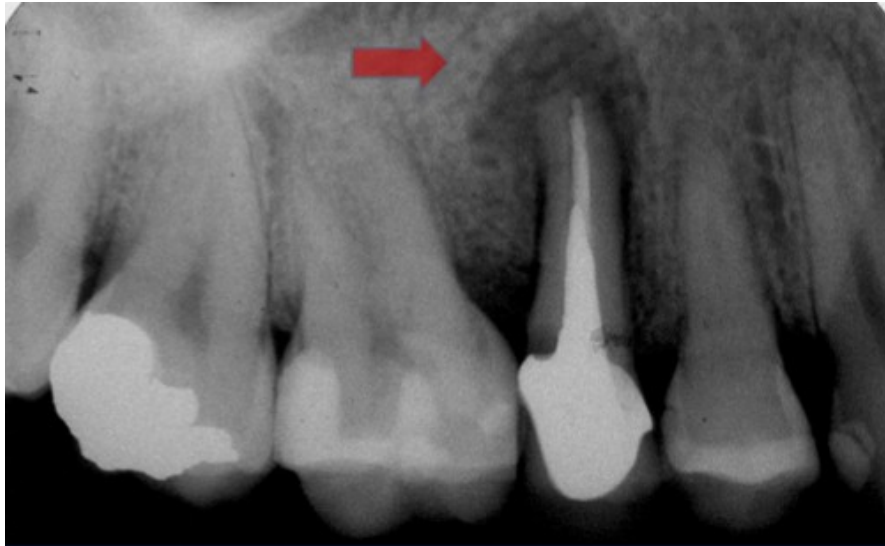
ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Área radiolúcida de formato circular ou ovoide, de tamanhos variáveis, bem delimitada, podendo estar ou não circundada por um halo radiopaco.

Os aspectos radiográficos não são suficientes para o diagnóstico diferencial entre um granuloma e um cisto periapical, necessitando-se de critérios histopatológicos para isto.

Tal área representa a formação de tecido de granulação como resposta primária do organismo aos processos inflamatórios que acometem a polpa dentária.

No granuloma temos um tecido de granulação, segurando a infecção no conduto/raiz, não deixando que vá para o osso.

O Granuloma tem no máximo 1cm.



O granuloma é circunscrito e delimitado

CISTO PERIAPICAL



HIPÓTESE: Cavidade patológica revestida por epitélio (restos epiteliais de Malassez).

Possui um conteúdo fluído, semifuído ou sólido.

Sendo assim, o paciente é assintomático.

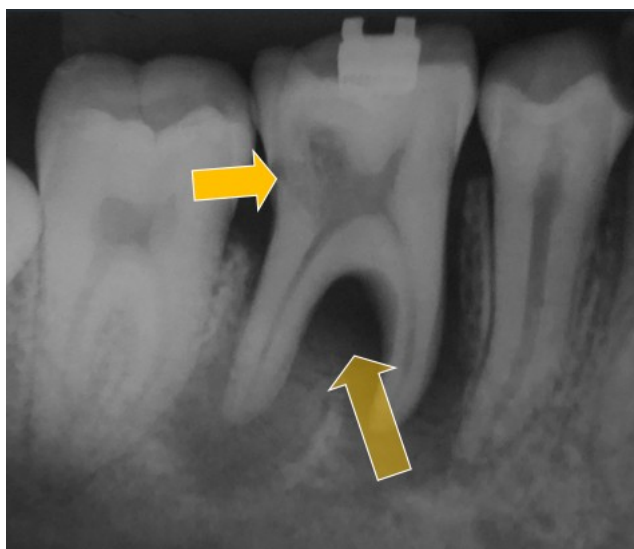
Este tipo de cisto, será ROPCC = Rarefação óssea periapical circunscrita cístico.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Área radiolúcida circular ou ovoide com margens bem definidas e na maioria das vezes circundada por um halo radiopaco.

Localiza-se na região periapical de dentes sem vitalidade pulpar.

LESÃO ENDO-PERIO

Uma alteração patológica proveniente da associação das doenças periodontal e endodôntica em um mesmo elemento dentário.



Este elemento dentário (1MID) não está “preso” em tecido de suporte. Podemos realizar o tratamento com uma endo, e uma periodontia, e o tecido irá regenerar.

Tipo de lesão de ápice	Sigla	Significado da sigla
Abcesso Periapical Crônico	ROPD	Rarefacção Óssea Periapical
Granuloma	ROPC	Rarefacção Óssea Periapical Circunscrita
Cisto Periapical	ROPCC	Rarefacção Óssea Periapical Circunscrita Cística

ANOTAÇÕES

21

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral

Aula ministrada pela Profa. Dra. Marina Reis Oliveira, em 10 de outubro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo.

Úlcera Traumática



A mordedura foi causada pelo terceiro molar, em estágios iniciais.

Sinais Clínicos:

PONTOS-CHAVE

Área de eritema que circunda uma membrana removível central, amarelada e fibrinopurulenta, amolecida à palpação, APENAS EM ESTÁGIOS INICIAIS.

Em alguns casos a lesão desenvolve uma borda branca e *corrugada de hiperqueratose*, imediatamente adjacente à área de úlcera.

Sintomatologia:

Sintomático.

Etiologia:

Trauma (mordeduras, restaurações e próteses mal adaptadas).

Diagnóstico:

Clínico. **Tratamento:**

Remover a causa da irritação.

Reduzir a dor. Laser de baixa potência. Omcilon A-orabase.



Doença de Riga-Fede



Sinais Clínicos:

Úlcera em superfície ventral e/ou dorsal da língua. **Sintomatologia:**
Sintomático. Dificuldade de amamentação/ alimentação do bebê.

Etiologia:

Traumatismo crônico da mucosa por dentes decíduos anteriores natais ou neonatais supranumerários ou não (mais frequentemente entre 1 semana e 1 ano de idade).

Diagnóstico:

Clínico.

Tratamento:

Desgaste incisal.
Remover dentes natais ou neonatais.

Presença de debilidade nutricional (quando a rizogênese está em estágio inicial). Mobilidade dentária. Rizogênese em estágio inicial. Lesões extensas.

Dois tipos:

1. Conservador

Paciente 28 dias.

Discreto comprometimento na alimentação.

Sem mobilidade importante.



Apresenta comprimento radicular.



Dentes 71 e 81

Iremos realizar o desgaste do bordo incisal e a aplicação de verniz fluoretado.

2. Radical

Normalmente...

Paciente 6 dias.

Comprometimento nutricional.

Perda de peso.

Queimaduras Eléctricas



As queimaduras elétricas constituem aproximadamente 5% de todas as admissões de queimados nos hospitais. Muito comum em crianças com menos de 4 anos de idade. Lábio e comissura labial são mais afetados. Pode ocorrer paralisia do nervo facial. Com perda de substâncias.

Sinais Clínicos:

Úlceras. Amareladas e carbonizadas. Edema. Sangramento (no momento, ou Desvitalização de dentes adjacentes, em região de maxila, pois o osso é mais poroso - "mais fraco". Necrose óssea na maxila. Ocorre mais em região de maxila.

Sintomatologia:

Sintomático.

Etiologia:

Trauma. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Imunização contra o tétano.

Antibiótico para prevenir infecção secundária (amoxicilina).

Laser de baixa potência.

Queimaduras Térmicas



Normalmente, em cavidade oral, a queimadura térmica se dá quando tomamos ou comemos algo quente, e consequentemente há sinais de queimaduras térmicas. **Sinais Clínicos:**

Eritema (pode estar presente ou não).

Ulceração que exibem remanescentes necróticos. **Sintomatologia:**

Sintomático.

Etiologia:

Ingestão de alimentos e bebidas muito quentes. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Paliativo com laser de baixa potência.

Necrose Anestésica



Sinais Clínicos:

Úlcera e/ou necrose no local da punção anestésica, que desenvolve-se vários dias após o procedimento.

Sintomatologia:

Sintomático. **Etiologia:**

Administração de anestesia local (mais comum no palato). Área pouco vascularizada. Grandes volumes anestésicos. Isquemia. **Diagnóstico:**

Clínico.

ANOTAÇÕES

22

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 2)

Tratamento:**PONTOS-CHAVE**

Paliativo com laser de baixa potência.

Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUNA)**Sinais Clínicos:**

Necrose da papila interdental - papila invertida, membrana fibrinopurulenta e sangramento espontâneo, linfadenopatia, febre, mal estar, odor fétido.

Úlceras na área gengival. **Sintomatologia:**

Dor intensa.

Gosto metálico.

Frequente em jovens e adultos jovens.

Pode levar a periodontite ulcerativa necrosante, quando não tratada. **Etiologia:**

Estresse (principal fator etiológico).

Imunossupressão.

Tabagismo.

Trauma local.

Deficiência nutricional.

Má higiene oral.

Sono inadequado. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Profilaxia profissional cuidadosa, com anestesia.

Remoção do material necrótico.

Orientação de higiene bucal.

Irrigação local com água oxigenada + bochechos com água oxigenada 10 volumes na proporção 1:1. Como são bactérias anaeróbias, não gostam de oxigênio, ou seja, temos que devolver O₂, por isso a água oxigenada.

Antibioticoterapia que combatam bactérias anaeróbias.

Orientações de repouso, ingestão de muito líquido e dieta nutritiva.

Herpangina



Manifestação em adulto, pouco comum, é raro. Comum em crianças que acabaram de nascer.

Sinais Clínicos:

Ulcerações de 3 a 4mm de diâmetro, frequentes em palato mole.

Comum em bebês e crianças. **Sintomatologia:**

Dor de garganta.

Febre.

Disfagia.

Tosse.

Vômito.

Diarréia.

Cefaléia. **Etiologia:**

Infecção viral (coxsackie). **Transmissão:**

Via fecal-oral ou por gotículas respiratórias expelidas durante espirros e tosse. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Controle de febre e dor.

Hidratação.

Anti-inflamatório. As lesões regredem de 7 a 10 dias.

Doença das mãos, pés e boca

**Sinais Clínicos:**

Erupções cutâneas e orais.

Lesões orais precedem as cutâneas e podem ser numerosas.

Comum em bebês e crianças. **Sintomatologia:**

Semelhantes a Herpangina. **Etiologia:**

Infecção viral (coxsackie). **Transmissão:**

Via fecal-oral ou por gotículas respiratórias (espirros e tosse). **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Controle de febre.

Dor.

Hidratação.

Anti-inflamatórios.

As lesões regredem de 7 a 10 dias.

Úlceras / Erosões por neoplasias

CEC (câncer) de borda lateral de língua.



CEC (câncer) de lábio.

Sinais Clínicos:

Qualquer úlcera que persista por mais de 10 a 12 dias sem cicatrizar deve ser biopsiada.

Sintomatologia:

Frequentemente, assintomáticas. E quando começa a doer, significa que a lesão já está presente por alguns meses.

Sempre devemos observar: 1. Tempo de duração. 2. Endurecimento ou espessamento. 3. Avaliar se está fixada às estruturas adjacentes. 4. Ausência de sintomatologia. **Etiologia:**

Neoplásica. **Diagnóstico:**

Biópsia incisional. **Tratamento:**

Cirurgia.

Radioterapia (exceto em câncer de lábio) e/ou quimioterapia.

Estomatite Aftosa Recorrente

Doença benigna muito comum e recorrente, que afeta preferencialmente a MUCOSA NÃO QUERATINIZADA, com etiologia desconhecida, e alguns fatores predisponentes:

Alergias e deficiência nutricional.

Predisposição genética (períodos hormonais em mulheres, antes da menstruação)

Influências hormonais.

Fatores imunológicos.

Agentes infecciosos.

Estresse e trauma.

Manifestações de doenças sistêmicas.

ANOTAÇÕES

23

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 3)

É dividida em três grandes subtipos:

1. Ulceração aftosa menor (afta vulgar ou de Mikulics). 2. Ulceração aftosa maior (Peradenite Mucosa Necrótica Recorrente Cicatrizante OU Afta de Sutton). 3. Ulceração aftosa herpetiforme.

1. Ulceração Aftosa Menor



Sinais Clínicos:

PONTOS-CHAVE

Úlcera de bordos rasos, circundada por um halo eritematoso (sempre), o fundo é de coloração branco-amarelada ou acizentada. -

Pode ser única mas na maioria das vezes é múltipla.

Tem caráter auto-limitante.

Sem etiologia definida.

Mede, frequentemente, de 5 a 7 mm.

Pode se manifestar num período de 7 a 14 dias.

Sintomatologia:

Dolorosa.

Diagnóstico:

Clínico.

Tratamento:

Suporte com laserterapia e Oncilom A em orabase.

2. Ulceração Aftosa Maior

**Sinais Clínicos:**

Variante mais agressiva, bordos irregulares, pontos avermelhados.
Podem acometer qualquer região da mucosa bucal (palato duro ou mucosa queratinizada).
O diâmetro pode chegar até 40 mm = 4cm.
Pode se manifestar múltipla ou unicamente. **Sintomatologia:**
Dolorosa.
Enfartamento ganglionar do lado afetado. **Diagnóstico:**
Clínico. **Tratamento:**
Suporte com laserterapia e Oncilom A em orabase.

3. Ulceração Aftosa Hepertiforme**Sinais Clínicos:**

Bordos rasos (quase ao nível da mucosa), mais rasa que a ulceração aftosa menor.
Apresenta de 1 a 3 mm.
São numerosas (assemelha-se a infecção primária pelo Herpes Simples).
Pode acontecer em qualquer idade. **Sintomatologia:**
Dolorosa. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

Suporte com laserterapia e Oncilom A em orabase.

As lesões regredem de 7 à 10 dias.

Úlcera Oral por Neutropenia

Baixa imunidade.

Lesões Vesículo Bolhosas

Diferença de vesícula e bolha, é o tamanho. A vesícula é menor que 5mm, e a bolha é maior que 5mm.

Gengivoestomatite Herpética



Etiologia:

Infecção primária pelo HHV 1.

É comum na infância (6 meses a 5 anos de idade), o pico de prevalência é de 2 a 3 anos.

Mais raras mas podem ocorrer em pacientes mais velhos. **Sintomatologia:**

Febre, cefaléia e aumento de linfonodos submandibulares.

Incubação +/- 6 dias.

Sinais Clínicos:

Diversas vesículas puntiformes que rapidamente se rompem e formam inúmeras lesões pequenas avermelhadas.

Aumentam pouco de tamanho e desenvolvem áreas centrais de ulceração recobertas por fibrina amarela.

Lesões se coalescem e formam ulcerações maiores rasas e irregulares.

Gengiva aumentada, eritematosa e dolorosa.

Erosão da margem gengival.

Diagnóstico:

Clínico.

Esfregaço citológicos das vesículas rompidas, são usados para detectar os corpos de inclusões virais.

Transmissão:

Saliva infectada.

Lesões periorais ativas.

Auto inoculação: dedos, olhos e áreas genitais. **Tratamento:** Suporte:

Analgésico e antitérmico.

Alimentação líquida e repouso.

Anestésico tópico.

Restringir contato com lesões ativas para prevenir disseminação.

Evitar contato com os olhos. O vírus pode tornar-se adormecido no gânglio trigeminal e, em um período posterior, sofrer reativação e causar infecção secundária recorrente.

Herpes Simples (Herpes Recorrente ou Herpes Labial)



Etiologia:

Causado pela reativação do vírus herpes simples. **Fatores Desencadeantes:**

Sol.

Trauma.

Estresse.

Baixa imunidade. **Sinais Clínicos:**

Inúmeras vesículas, preenchidas por líquido, aparecem comumente no lábio ou ao lado da asa do nariz.

Vesículas rompem formando crostas, em 2 dias.

Cicatrização de 7 a 10 dias.

ANOTAÇÕES

24

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 4)

Sintomatologia:

Sinais prodômicos - 6 à 24 horas ANTES.

PONTOS-CHAVE

Dor.
Ardência.
Prurido.
Picotamento.
Calor.
Eritema.
Pontadas.

Se o paciente consegue identificar os sinais, antes de estourar as vesículas, fazer compressas com gelo.

Diagnóstico:

Clínico.

É comum em adultos jovens com envolvimento intra-oral. As vesículas se rompem formando úlceras dolorosas.

Tratamento:

É melhor na fase prodômica.

Antivirais: Aciclovir - Zovirax (inibe a síntese de DNA viral).
Tópicos - creme: 5x ao dia por 4 dias.
Sistêmico- comprimido: 200mg 5x ao dia, 400mg 3x ao dia, 800mg 2x ao dia por pelo menos 5 dias.
Laserterapia de baixa potência.

Panarício Herpético (Paroníquia Herpético)

Lesões em dedos.
Auto-inoculação.
Era comum em dentistas antes do uso de luvas.
Podem resultar em parestesia e cicatrizes.

Varicela Zoster (Catapora)



Infecção Primária. **Etiologia:**

Vírus varicela-zoster (VZV ou HHV 3). **Transmissão:**

Disseminação de gotículas ou contato direto.

Maioria na idade entre 5 e 9 anos.

Incubação de 10 a 21 dias / média de 15 dias. **Sinais Clínicos:**

Acometimento de pele e mucosa oral. Eritema. Vesícula. Pústula. Úlceras. Crostas endurecidas. As lesões podem preceder as lesões cutâneas.

Sintomatologia:

Febre.

Cefaléia.

Calafrio.

Mal-estar.

Faringite.

Rinite.

Mialgia.

Complicações como pneumonia e encefalite podem ocasionalmente ocorrer.

Torna-se mais grave quando acomete idosos.

Diagnóstico:

Clínico.

Tratamento:

Sintomático: banhos mornos com bicarbonato ou permanganato de potássio; analgésicos; antipiréticos.

O vírus pode torna-se adormecido no gânglio trigeminal e, em um período, sofrer reativação e causa infecção secundária recorrente.

A vacina existe desde 1974, com 98% de eficácia em casos graves. A vacina deve ser tomada após 6 meses da não reativação do vírus.

Herpes Zoster

**Etiologia:**

HHV 3 (vírus em latência do gânglio espinha dorsal - reativação).

10 a 20% dos indivíduos adultos (risco aumenta com a idade).

Apenas uma recorrência é esperada.

Fases prodrômicas, aguda e crônica. **Diagnóstico:**

Clínico. **Sintomatologia:**

Dor.

Queimação.

Ardência perfurante, há incomodo ou cortante. **Sinais Clínicos:**

Vesículas se rompem e deixam úlceras dolorosas.

A localização comum inclui o tronco, cabeça e pescoço (envolvimento intra-oral é raro).

Lesões orais com envolvimento do nervo Trigêmio.

A neuralgia pós-herética é uma complicação em aproximadamente 10% dos pacientes com herpes zoster.

Envolvimento ocular - cegueira. **Tratamento:**

Anti-virais em altas doses.

Tratamento de suporte:

Febre - antipiréticos (que não contenham aspirina): Síndrome de Reye.

Lesões cutâneas secas e limpas para evitar infecção secundária.

Lesões bucais que se apresentam como bolhosas:

Líquen Plano.

Pênfigo Vulgar.

Penfigoide das Membranas Mucosas.

Eritema Multiforme.

Epidermólise Bolhosa.

Líquen Plano



Muco-cutânea.

Comum.

1% e 4% da população tem líquen plano cutâneo.

Líquen plano oral prevalência de 0,1 a 2,2%.

Adultos.

Etiologia:

Incerta.

Desordem muco-cutânea mediada imunologicamente.

Processo imunológico desencadeado por um “antígeno” que altera os queratinócitos da camada basal tornando-os suscetíveis à resposta imune celular. Isto induz a ativação de linfócitos TCD4+ e TCD8+ e

citocinas inflamatórias que levam à apoptose dos queratinócitos.

Desordens psicológicas e estresse.

Sinais Clínicos

PELE:

Pápulas poligonais pouco elevadas.

Superfícies flexoras.

Sintomatologia: prurido.

OUTRAS LOCALIZAÇÕES:

Mucosa genital.

Unhas.

MUCOSA ORAL:

Reticular. Mais frequente. Assintomático. Caracteriza-se por estrias brancas que se entrelaçam (Estrias de Wickham).



Erosivo. Áreas erosivas atróficas com graus variáveis de ulceração central (pode ser visto na periferia destas lesões). Sintomático.



ANOTAÇÕES

25

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Lesões Ulcerativas e Erosivas da Mucosa Oral (parte 5)

PONTOS-CHAVE

Atrófico (eritematoso).

Bolhoso.

Placa.

Gengivite descamativa. **Diagnóstico:**

Clínico + Biópsia (histopatológico). **Tratamento:**

Corticoide tópico ou sistêmico.

Tacrolimus (imunossupressor tópico).

Laser.

Pênfigo Vulgar



É um grupo de doenças auto-imune nas quais o DESMOSSOMO é destruído. **Tipos clínicos:** Vulgar. Vegetante. Eritematoso. Foliáceo.

BOCA:

Primeiro lugar a aparecer e último a ceder ao tratamento.

Incidência 1 a 5 casos / 1 milhão na população no ano.

50 anos.

Não há predileção por sexo. **Etiologia:**

Autoimune.

Produção de auto anticorpos contra uma glicoproteína (desmogleína 3) da superfície celular do epitélio, que é componente dos desmossomos. **Sinais Clínicos:**

Formação de bolha intraepitelial (fenda intraepitelial).

Células deixam de ter formato poliédrico para serem arredondadas (células de Tzank) - acantólise do epitélio.

Erosões e ulcerações superficiais e irregulares.

Dor.

Sinal Nikolsky positivo.

Gengivite descamativa. **Diagnóstico:**

Clínico + Biópsia (histopatológico). **Tratamento:**

Corticóide.

Outras drogas imunossupressoras (azatioprina).

Controle do paciente - recidivas.

Penfigóides

Família das doenças crônicas imunomediadas nas quais se formam bolhas subepiteliais.

Grupo de doenças na qual são produzidos autoanticorpos contra componentes da membrana basal.

Penfigóides das Membranas Mucosas



2 vezes mais comum que o pênfigo vulgar.

Maioria tem lesões em boca.

Adultos acima de 60 anos.

Mulheres 2:1.

Oral, ocular, nasal, esofageano, laringeano, vaginal e pele. **Etiologia:**

Autoanticorpos contra um ou mais componentes da membrana basal (hemidesmossomos).

IgG contra a membrana basal. **Sinais Clínicos:**

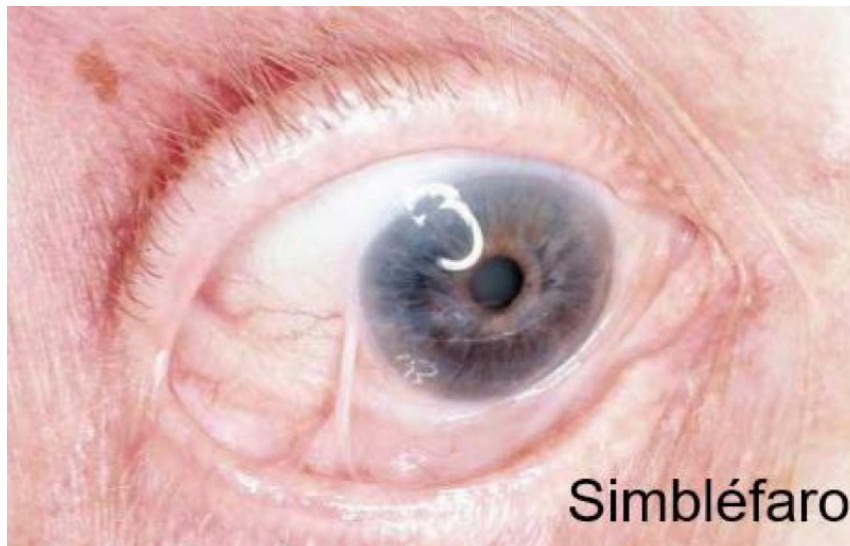
Bolhas subepiteliais (fenda subepitelial), úlceras.

Sintomatologia dolorosa intensa.

Gengiva (gengivite descamativa), palato duro.

Ocular em 25% dos pacientes.

Simbléfaro (fibrose que prejudica o movimento ocular).



Simbléfaro

Entropia (fusão das pálpebras).
Triquíase (eversão dos cílios).
Queratinização da mucosa ocular). **Diagnóstico:**
Clínico + Biópsia (histopatológico). **Tratamento:**
Corticoide.
Ciclofosfamida.
Tracolumus.
Agentes imunomoduladores.
Tratamento com oftalmologista.

Eritema Multiforme

Reação de hipersensibilidade.
Terceira e quarta décadas de vida (adultos jovens: 20 — 30 anos).
Sinais prodromáticos, quando acontecem, aparecem 1 semana antes (febre, mal estar, dor de cabeça, tosse e dor de garganta).
Esporádico ou recidivante.
Agudo ou auto-limitante (perdura por 2 a 6 semanas).
20% de recidiva.

EM MENOR:

Mais raro nas mucosas.
Baixa severidade.

EM MAIOR:

Mucocutâneo.
Mais grave.
Envolvimento bucal genital, cutâneo e ocular.

BOCA: lesões maiores e mais abrangentes.

Fatores predisponentes:

Infecção precedente (herpes simples, micoplasma pneumoniae).
Reação a drogas (anticonvulsivante, barbitúricos, anti-inflamatórios).

Etiologia:

Peptídeos antigênicos formam complexos com IgG fixadoras do complemento e atacam vasos sanguíneos.

Sinais Clínicos:**PELE:**

Lesões em alvo (halo eritematoso, circunscrito com bolhas no centro).

Ocorre em superfícies flexoras e extremidades.

Comum ocorrer simetria (ou seja, nas duas mãos)

BOCA:

Placas eritematosas que sofrem necrose e evoluem para grandes erosões e ulcerações. **Diagnóstico:**

Clínico. **Tratamento:**

EM MENOR: corticóide tópico.

EM MAIOR: corticóide sistêmico.

Tratamento da desidratação, quando necessário.

Stevens-Johnson: 2% a 10% óbito.

ANOTAÇÕES

26

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Pseudocistos

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Claudio Froes, em 3 de Outubro de 2022, na Universidade Cidade De São Paulo.

O Pseudocisto radiograficamente lembra um cisto, mas clinicamente não obedece as características de um cisto.

CISTO ÓSSEO SIMPLES Lesão traumática interna da mandíbula

É muito característico deste cisto se insinuar entre as raízes dos dentes, e isso chamamos de limites festonados “interdigitações”. Ou seja, não destrói lâmina dura, não há mobilidade e nem uma aparência escura.

Características:**PONTOS-CHAVE**

ETIOLOGIA: trauma, hemorragia intraóssea formando uma cavidade óssea vazia ou contendo líquido sanguinolento.

OBSERVAÇÃO RADIOGRÁFICA: imagem radiolúcida bem delimitada, a qual se insinua entre as raízes dos dentes próximos a lesão.

Incidência expressivamente maior na mandíbula e discretamente maior no gênero masculino.

Com predileção pelo sexo masculino.

CISTO DE STAFNE Defeito ósseo de desenvolvimento da mandíbula

**Características:**

Cavidade focal de osso cortical na superfície lingual da glândula salivar.

OBSERVAÇÃO RADIOGRÁFICA: área radiolúcida entre a base da mandíbula e o canal da mandíbula.

Geralmente unilateral.

Está localizado entre o canal da mandíbula e a base da mandíbula.

Este tipo de cisto não há tratamento, pois é um cisto feito de glândula salivar submandibular.

ANOTAÇÕES

27

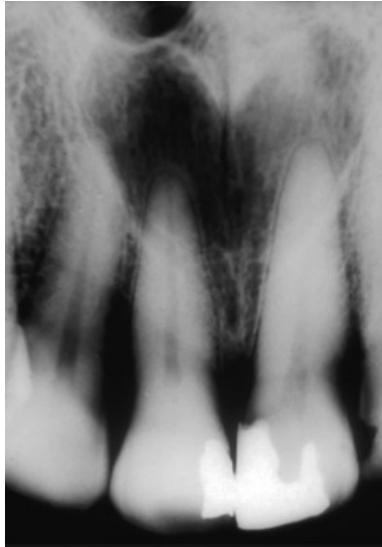
AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Cistos Não Odontogênicos

Aula ministrada pelo Dr. Prof. Claudio Froes, em 3 de Outubro de 2022, na Universidade Cidade De São Paulo.

Dois tipos: 1. Cisto Nasopalatino ou Canal Incisivo. 2. Cisto Nasolabia ou Nasoalveolar.

CISTO NASOPALATINO ou CANAL INCISIVO



Tem uma predileção pelo sexo masculino. E se encontra entre os incisivos centrais superiores (ICS). E os dentes apresentam uma vitalidade pulpar.



Este tipo de cisto possui uma forma de coração, arredondada ou ovalada

Se encontra, normalmente, em palatina dos dentes, ou seja, sem relação, por isso que é um cisto NÃO odontogênico.

É uma área radiolúcida bem circunscrita, e se encontra na linha média da maxila.



Cisto NÃO odontogênico com o palato ósseo abaulado.

CISTO NASOLABIAL



Ocorre a nível da prega nasolabial, abaixo da asa do nariz.

Observação radiográfica: aspiração do conteúdo cístico e injeção de contraste.

Não mostram imagens de destruição óssea (compressão óssea/ erosão superficial).

Temos a perda do sulco nasolabial, e a elevação da asa do nariz.

ANOTAÇÕES

28

AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Biópsia e Citologia Esfoliativa

Aula ministrada pela Profa. Dra. Karin Sá Fernandes, em 5 de setembro de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo

CITOLOGIA ESFOLIATIVA

Obtenção de células de superfície por raspagem para avaliação

Materiais utilizados:**PONTOS-CHAVE**

- Lâmina de vidro;
- Citobrush;
- Recipiente;
- Clipes;
- Fixar em álcool absoluto;
- Ficha com dados do paciente;

Fazer no mínimo 2 lâminas da mesma região.

Colocar em recipiente com álcool 96% separando-as com clipes

Classificação:

Classe 0: material inadequado ou insuficiente.

Classe I: células normais.

Classe II: células com características inflamatórias, mas sem evidência de malignidade.

Classe III: células sugestivas de malignidade.

Classe IV: células fortemente sugestivas de malignidade.

Classe V: Citologia conclusiva de malignidade.

III, IV e V = obrigatória a realização da BIÓPSIA.

Cuidados durante o exame citológico:

- Falha de coleta;
- Limitação de qualidade para análise;
- Erro na técnica;
- Falsos positivos/negativos;
- Presença de necrose. BIÓPSIA

Remoção de tecido e um ser vivo para exame diagnóstico microscópio.

Iremos fazer a biópsia para descartar e para saber o diagnóstico da lesão.

Indicações:

- Qualquer lesão que necessite diagnóstico histopatológico;
- Lesões com diagnóstico citológico III, IV e V;
- Úlceras que permaneçam mais de 20 dias sem regressão;

Contra-indicação:

Impedimentos sistêmicos.

TIPOS DE BIÓPSIA:

Incisional: Lesões extensas com suspeita de malignidade.

Excisional: Lesões pequenas e não há suspeita de malignidade.

Aspirativa: Mais utilizados por médicos, pois é o diagnóstico de regiões maiores (ex. parótida). Aspirar células para explorar a lesão ou diagnóstico histopatológico.

Materiais utilizados:

Escovas e sabão para lavagem das mãos.

Luvas estéreis.

Material descartável estéril.

Pinça Allis = para assepsia extra-oral.

Clorexidina 2% para assepsia extra-oral.

Clorexidina 0.12% para assepsia intra-oral.

Carpule, anestésico e agulha.

Cabo de bisturi com lâmina ou punch.

Afastador de tecido.

Tesouras pequenas.

Pinça.

Porta agulha.

Fios de sutura 3.0 ou 4.0.

Folha de dados para biópsia.

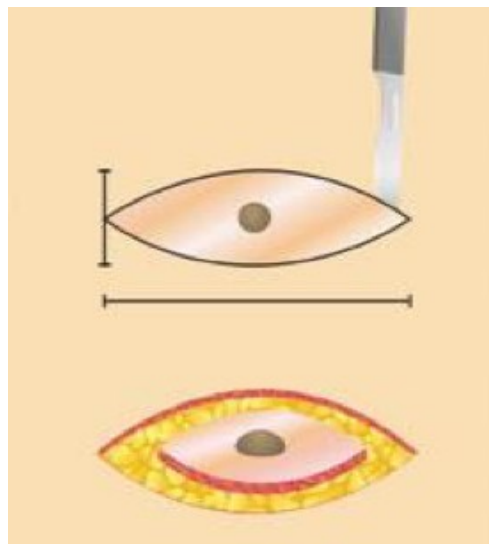
Formol 10%.

Técnica da Biópsia:

Cuidados com paramentação e material cirúrgico.

Anestesia longe da área de incisão, ou seja, anestesiando em volta da incisão.

Incisão em forma de elipse ou cunha.



Cuidado para não marcar o tecido com a pinça durante a remoção.

Colocar a peça cirúrgica em solução de formol 10%, sendo que o volume deve ser 10 vezes maior que a peça.

A peça deve permanecer pelo menos 24hrs fixando antes de ser processada.

Relatório completo (dados do paciente, características da lesão, tipo de biópsia, sintomatologia, radiografias).

Orientações de pós-operatório.

PASSO A PASSO:

ANESTESIA:

1. Montagem da seringa carpule

1.1 Para inserir o tubete de anestésico na Carpule, é necessário tracionar a haste-êmbolo da mesma, provocando, assim, uma desarticulação entre o corpo e a empunhadura da seringa. Com isso, exhibe-se a loja receptácula do tubete, que deve ser inserido com o anel metálico voltado para o local onde será atarraxada a agulha.

1.2 Para expor o terminal da agulha que será acoplado à Carpule e que violará o lacre do tubete anestésico, gire a tampa em sentido horário e anti-horário.

Em seguida, coloque a agulha na Carpule, rosqueando-a. Observar que a agulha deverá estar alinhada com o corpo da Carpule, mantendo-se o eixo de inserção. Depois, retire o invólucro protetor.

1.3 Empunhadura da seringa: dígito-palmar e digital.

INCISÃO (CORTE)

1. Colocação da lâmina no cabo de bisturi

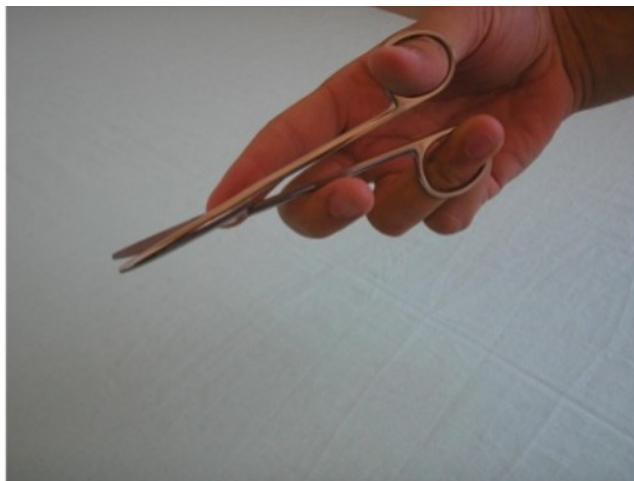
Empunhadura do bisturi em forma de caneta.



Fonte: LACE-UFCG

Inclinação adequada da lâmina no tecido – começar em 90°, seguir em 45° e terminar em 90° para que toda a extensão da incisão tenha a mesma profundidade.

Empunhadura da tesoura.



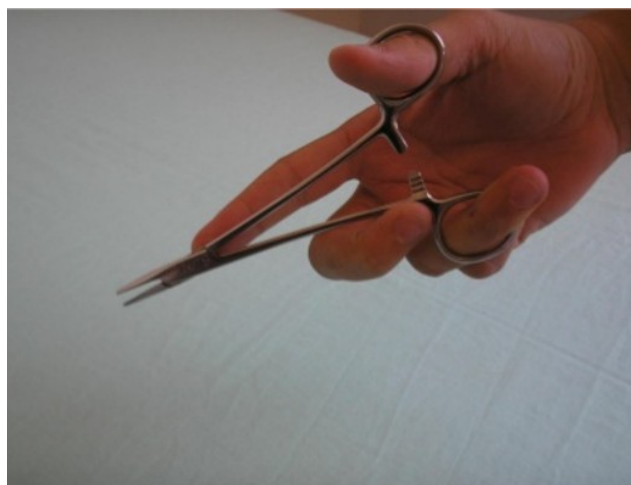
Fonte: LACE-UFCG

Empunhadura da pinça.



Fonte: LACE-UFCG

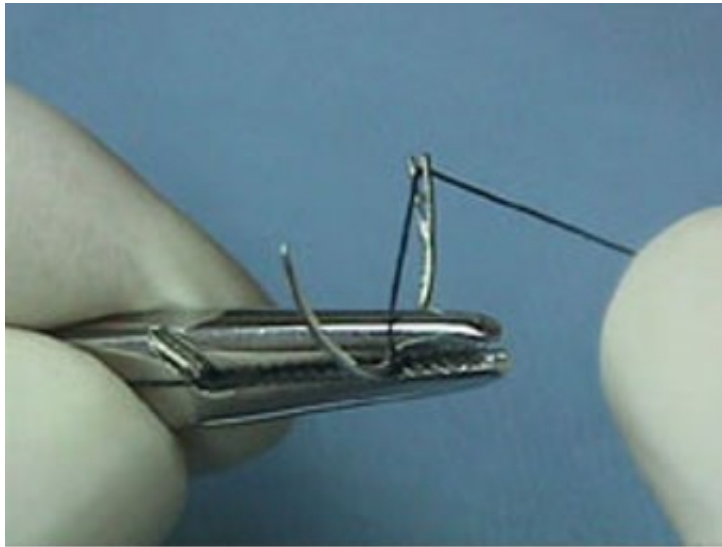
Empunhadura do porta agulha.



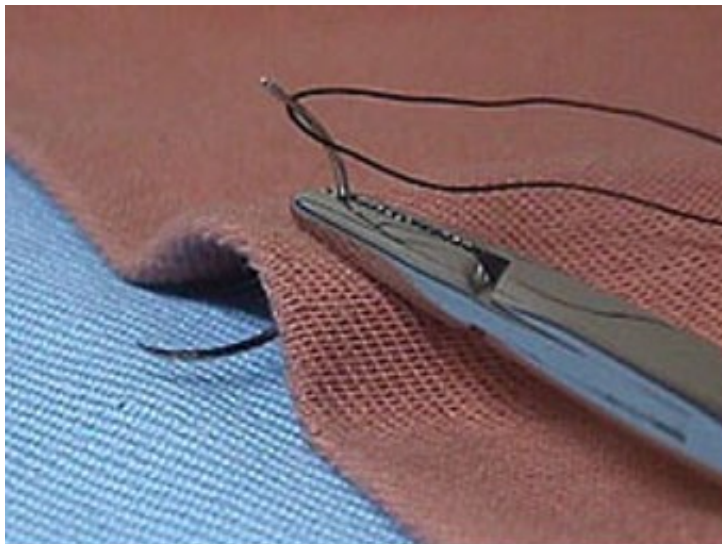
Fonte: LACE-UFCG

SUTURA

1. As suturas dos diferentes planos devem ser feitas de modo que não sobrem espaços entre as partes a serem unidas, assim como o tecido não deve ser tensionado pelos pontos dados. Sugere-se iniciar primeiro no centro e, depois, nas extremidades



Apreender a agulha no porta-agulhas



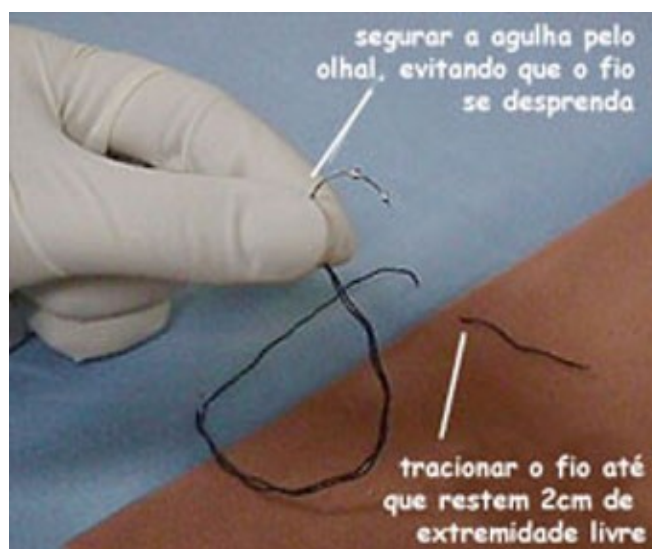
ANOTAÇÕES

29

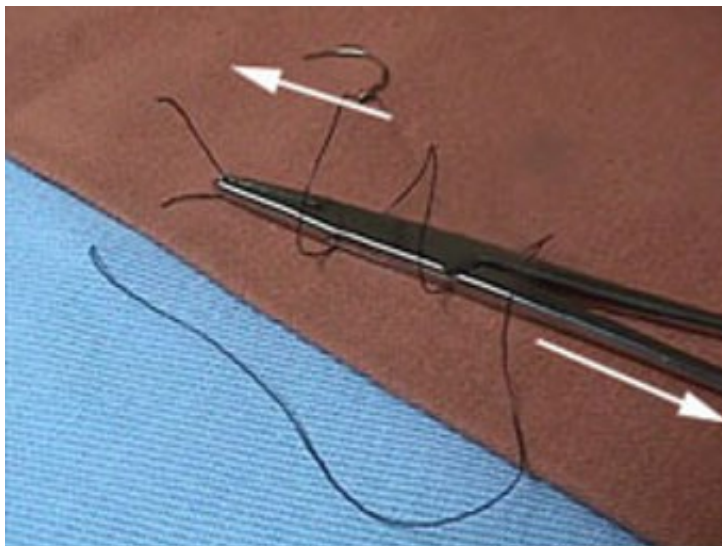
AULAS DE DIAGNÓSTICO INTEGRADO I E 2

Biópsia e Citologia Esfoliativa (parte 2)

Com movimento de rotação, transpassar a agulha inicialmente (Sugestão: 0,5 cm da borda da ferida de cada lado)

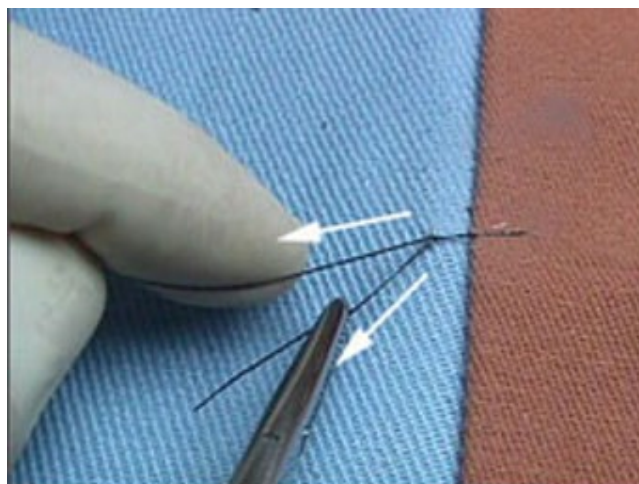
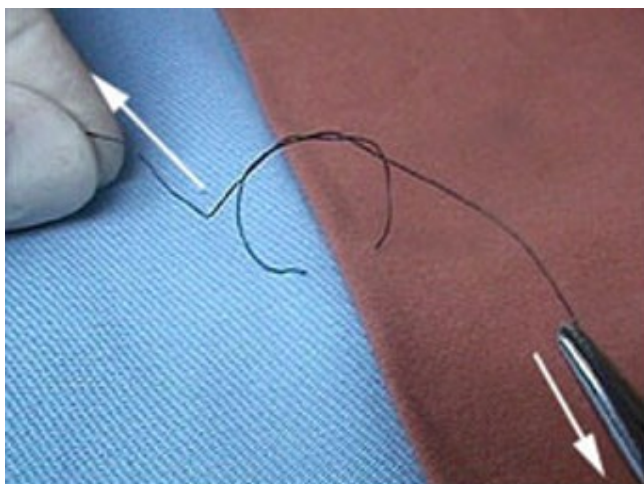


Trazer com movimento de rotação até livrar a quase totalidade do comprimento do fio, deixando apenas dois centímetros de extremidade livre.

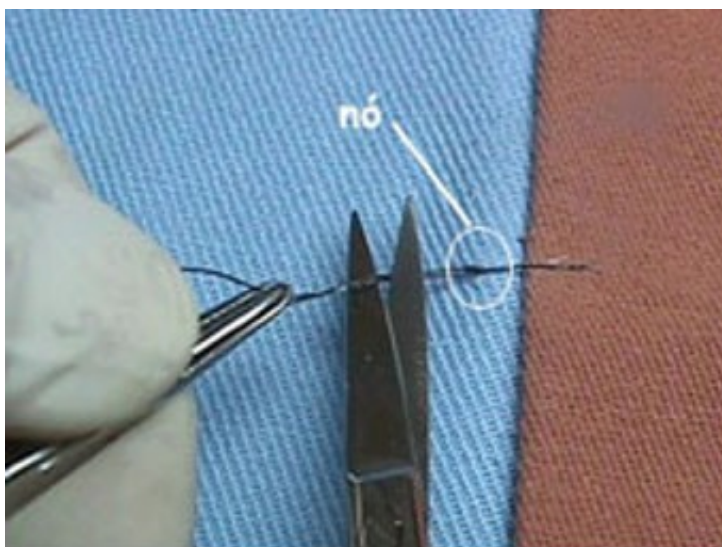


Dar duas voltas sobre a ponta ativa do porta-agulhas com o segmento maior da linha e pinçar, com a ponta ativa do porta-agulhas, a extremidade livre da linha.

Tracionar as extremidades da linha, de tal sorte a liberar as voltas da linha dadas no porta-agulhas, até que o nó se complete. Agora as duas pontas da linha deverão ser tracionadas em conjunto em direção a uma das bordas da "ferida".



Repetir essa operação mais duas vezes, de modo que dois nós se sobreponham, evitando assim o seu desatamento. Com isso, você concluiu um ponto de sutura. Devemos ressaltar que com fios de seda ou de catagute deverão ser dados, no mínimo, três nós, devido à facilidade de desatamento desses fios.



Tracione conjuntamente as extremidades do fio, para cortá-las a 3 mm da base do último sobrenó. Com isso, você finalizou o ponto de sutura.

Como remover o ponto de sutura (um passo)

Com uma pinça clínica, elevar delicadamente o nó e, com a tesoura de ponta aguda, cortar o segmento mais curto da linha que tende a mergulhar no tecido.

Tracionar suavemente o nó e o remanescente da linha, retirando-a



ANOTAÇÕES